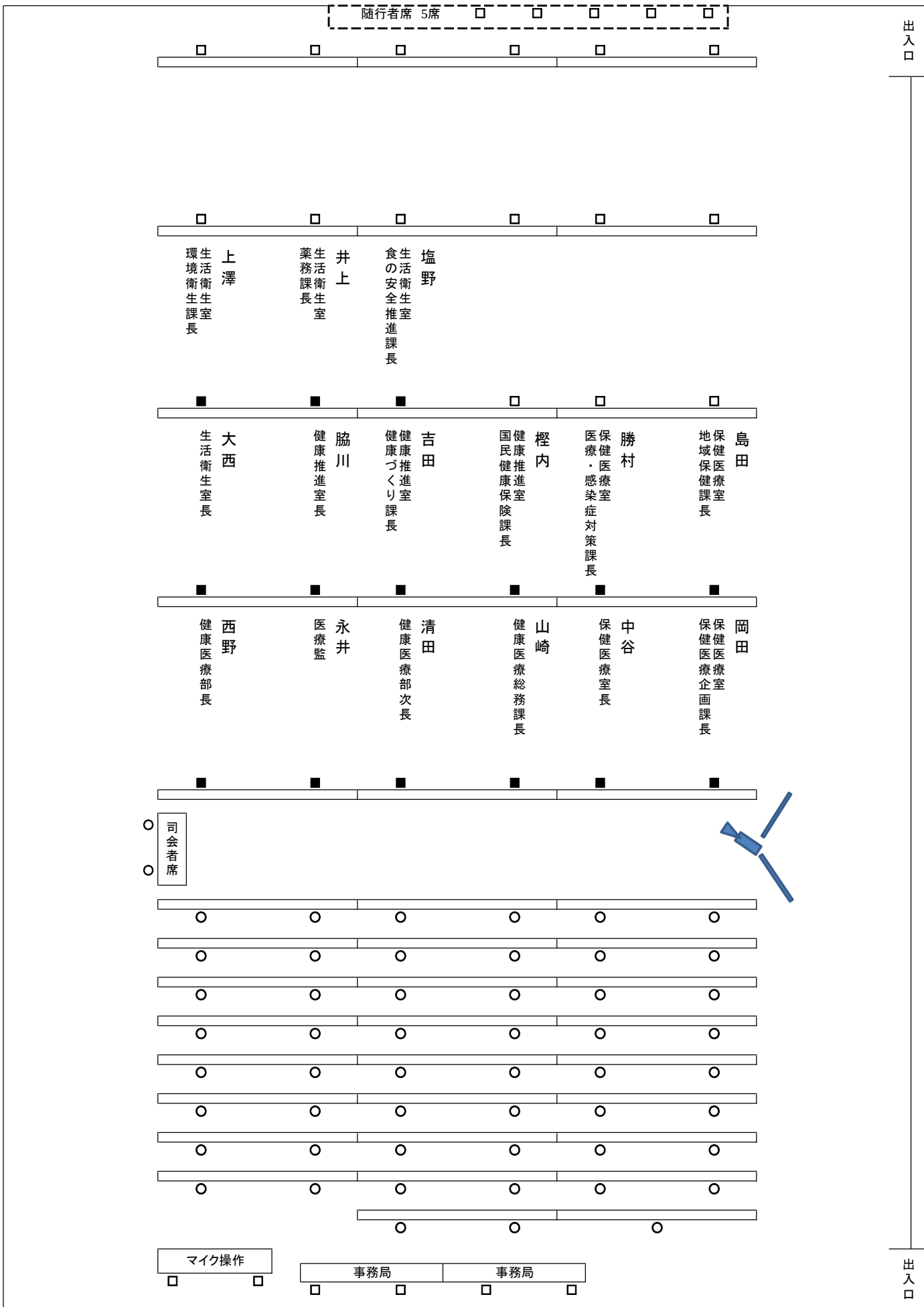


健康医療部

大阪維新の会 政調会 配席図【健康医療部】
令和8年2月12日(木) 第1委員会室



令和 8 年度当初予算案主要事業の概要

(健康医療部)

上段 令和 8 年度財務部長内示額
 中段 令和 8 年度知事復活要求額
 下段 令和 7 年度当初予算額

(一般会計)

※地域医療介護総合確保基金事業費については「基金」と記載

事業名	R 8 既内示額 R 8 復活要求額 (R 7 当初額)	摘 要
1. 地域医療の充実とこころの健康問題への対応強化		
(1) 保健医療基盤の整備を推進します		
① 保健医療計画推進事業費	2,780万円 － (2,121万円)	「第 8 次医療計画」の推進にあたっての具体的な方策や計画の進捗管理等とあわせて、「新たな地域医療構想」の策定に向けて、各医療圏に設置した大阪府保健医療協議会等で協議・検討を実施。
② 基金（医事事業）		
・ 病床機能分化・連携推進のための基盤整備事業	7億6,081万円 － (15億4,821万円)	地域医療構想を踏まえ、不足する医療機能の充実等を図るため、回復期病床等へ転換するための改修等や転換・再編等に伴う必要な人的経費、また、病床削減に伴う改修費用等に対し整備計画のある医療機関に補助。
・ かかりつけ医機能報告制度推進事業	1,537万円 － (1,537万円)	慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から報告された内容を府民に情報提供する体制を整備。
・ 死因調査等体制整備関連事業	1,475万円 － (554万円)	多死高齢社会に対応した、正確かつ適切な死因を特定する体制を整備するため、医師に対する死因診断研修や実習医への支援等を実施。また、監察医事務所で使用する死亡時画像診断に必要な C T 車に搭載した機器の更新を実施。

③ 死因調査等体制整備事業費 ・【拡充】監察医事務所老朽化対策調査・検討事業 ④ 医療安全支援センター運営事業費 ⑤ 医療機関情報システム運営事業費 ⑥ 【拡充】施設整備促進支援事業	899万円 — (499万円) 329万円 — (315万円) 3,939万円 — (3,872万円) 38億2,263万円 — (2億5,379万円)	大阪府内の死因究明等の推進に取り組む監察医事務所の老朽化対策として、現地建替えの実施に向け、建替え時の仮移転先にかかる設備等の調査を実施。 ○医療相談窓口整備事業 保健所内に医療相談窓口を整備するとともに、医療関係者・市民団体・行政等が情報交換を行い、地域において府民が気軽に医療に関する相談や助言を受けられる体制を整備。 ○医療安全対策指導者育成研修事業 府民が安心して医療機関を受診できるよう、医療機関における安全対策推進の中心となる指導者の育成を図るための研修を実施。 厚生労働省の医療機関等情報支援システム（G-MIS）及び医療情報ネット（ナビイ）を利用し、府民に対して府内の全医療機関（病院・診療所・歯科診療所・助産所）の医療機能に関する情報提供を実施。 現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備が困難となっている医療機関を対象として、建築資材高騰分等を補助。＜資料7＞
(2) 在宅医療体制の整備を推進します ①基金（地域医療事業） ・在宅医療体制強化事業	1億4,355万円 — (1億7,961万円)	24時間の往診体制を整備するために、在宅医の確保に向けた同行訪問を実施するとともに、医療機関や多職種間の連携体制を構築する医療機関及び連携拠点等の患者情報共有等の取組みに対し補助。

・在宅医療総合支援事業	1,311万円 － (1,311万円)	在宅医療における多職種連携や看取りにかかる研修、医療介護連携相談窓口人材の広域連携等の取組みに対し補助。
・在宅医療の普及促進事業	1,120万円 － (720万円)	医療介護従事者等を対象に、医師会・病院が行う在宅医療の理解促進に関する研修に対し補助。
・在宅医療移行支援事業	1,532万円 － (1,132万円)	在宅療養患者の病状変化時の受入れ体制を確保するため、退院支援や医療機関間の連携を推進する取組みや退院調整に携わる看護師等への研修の実施に対し補助。
・在宅医療サービス基盤整備推進事業	2億9,360万円 － (3億2,453万円)	第8次医療計画において、各圏域に設置する「在宅医療に必要な連携を担う拠点」及び「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」に求められる会議の開催や研修等の実施に対し補助。
・【拡充】「人生会議」相談対応支援事業	7,880万円 － (2,778万円)	人生会議（ACP）の実践を促進するため、看護師等のACP支援実践人材の育成を支援するとともに、府民向け啓発資料の配布を実施。また、「人生会議の日」に向けた府民向けイベントやラジオ放送等に加え、SNSやサイネージを活用した普及啓発を実施。 さらに、条例の制定を踏まえ、市町村が行う住民向けセミナーや事業者が行う職場研修への講師派遣等にかかる支援、高校生向け教材の作成、事業者及び府内児童・生徒への資料配布等を行うことで、啓発活動を強化。
②基金（歯科保健事業） ・在宅歯科医療における摂食・嚥下障害対応チーム育成事業	346万円 － (347万円)	地域における在宅医療分野での摂食・嚥下障害への対応を行う歯科医療人材育成にかかる研修の実施に対し補助。
③基金（看護事業） ・【拡充】訪問看護推進事業	1億1,043万円 － (1億815万円)	○訪問看護ネットワーク事業 医療ニーズが高い患者等の増加に対し、24時間365日対応等の訪問看護サービスの供

④基金（薬務事業） ・薬局の在宅医療推進事業	800万円 － (800万円)	給体制を整備するため、訪問看護ステーションが機能強化や規模拡大を図る取組みに対し補助。加えて、訪問看護師の離職防止のため、カスタマーハラスメント対策として、福祉部と共同で、相談窓口の設置や訪問看護事業所の利用者に対する啓発等を実施。 ○訪問看護師確保定着支援事業 訪問看護の安定的な供給を図るため、訪問看護の人材確保及び専門性の高い訪問看護師の育成にかかる取組みに対し補助。 患者が入院から在宅療養へ移行しても、同様の薬物療法を受けられるよう、薬局薬剤師と在宅医療に関わる多職種との連携強化、医療的ケア児や感染症等の感染拡大時の在宅訪問など高度・多様化する在宅患者ニーズに対応できる薬剤師の育成にかかる研修の実施に対し補助。
(3) 救急医療体制の充実に努めます ①救命救急センター体制整備事業費 ②基金（救急医療事業） ・救急搬送患者受入促進事業 ・特定科目休日夜間二次救急医療体制運営事業 ・小児救急医療体制整備事業	6億3,691万円 － (5億8,415万円) 6億9,120万円 － (6億5,482万円) 8,311万円 － (7,960万円) 2億5,682万円 － (2億4,705万円)	生命の危機を伴う重篤な救急患者に対する医療を担う救命救急センターの運営費及び設備整備費等に対し補助。 円滑な救急受入体制確保のため、要介護高齢者など搬送困難な患者を受入れる医療機関に対し補助。 休日・夜間における特定科目（眼科・耳鼻咽喉科）の二次救急医療体制を確保するため、輪番制による受入体制を整備。 ○小児救急医療支援事業 休日・夜間において入院治療が必要な小児救急患者の受入体制を確保するため、市町村が行う地域ブロック単位での体制確保にかかる人件費に対し補助。

③精神科救急医療体制整備事業費 ④救急医療情報システム整備運営事業費 ⑤【新】救急医療啓発事業	4億515万円 － (3億7,962万円) 3億4,882万円 － (3億940万円) 392万円 － (－)	○小児救急電話相談事業 夜間の子どもの急病時に保護者の不安を解消するため、小児科医の支援体制のもと、看護師による夜間電話相談を実施。 休日・夜間等における精神疾患等の症状の急発・急変に対応するため専門相談員が助言や精神科救急医療情報センターへの紹介等を行う医療相談体制を確保。 また、休日・夜間等の措置診察の実施や入院受入医療機関の確保及び精神・身体合併症患者が精神科・身体科双方の医療を受けられる体制等を整備。 救急医療機関等に関する情報を集約し府民にわかりやすく提供するとともに、より円滑で適切な救急患者の搬送及び受入れをめざし、消防・医療関係者間の情報ネットワークの根幹となるシステムを整備運営。 また、三次救急医療機関間のネットワークを活用し、受入困難事案に対応。 ヒートショックの危険度や予防方法及びAEDの使用方法的の周知啓発や設置促進を実施。
(4) 小児・周産期医療体制の充実を図ります ①周産期医療体制整備事業費	12億3,680万円 － (12億3,293万円)	○周産期母子医療センター運営事業 安心して子どもを産み育てることが出来る環境づくりの一環として、高度専門的な周産期医療を効果的に提供する周産期母子医療センターの運営に対し補助。 ○産婦人科救急搬送体制確保事業 かかりつけ医をもたない未受診妊婦等の救急搬送を休日・夜間等に受入れる医療機関を当番制により確保。 ○周産期緊急医療体制コーディネーター設置事業 緊急搬送が必要なハイリスク妊産婦の搬送先の調整を担う専任医師をコーディネー

②基金（母子保健事業） ・小児在宅医診療促進事業 ・小児医療・周産期医療連携推進事業 ③基金（地域医療事業） ・産科小児科担当医等手当導入促進事業 ④産科・小児科医療確保事業 ⑤【新】無痛分娩の安全な提供体制確保事業 ⑥【新】ドナーミルク利用支援事業	295万円 － (295万円) 6,991万円 － (6,991万円) 1億3,179万円 － (1億2,939万円) 5億8,320万円 － (3億9,600万円) 425万円 － (－) 120万円 － (－)	ターとして大阪母子医療センターに配置し、緊急搬送を円滑化。 医療的ケアの必要な小児に対する日常的な診療を担う在宅医を育成するための研修等を実施。 ○小児医療連携体制・受入体制構築事業 小児患者が増大する等の際に、一部医療機関への患者集中を防ぐため、地域の小児拠点医療機関にコーディネーターを設置するとともに、小児科医療機関間の連携体制構築に向けた検討を実施。 ○周産期緊急医療体制確保事業 危険な状態にある妊産婦や新生児を専門医療機関へ緊急に搬送し、適切な医療が受けられる体制を確保。 産科や小児科（新生児）に勤務する医師等の処遇改善のため、分娩手当等を支給する医療機関に対し補助。 周産期・小児医療体制の維持・確保のため、急激な分娩数や小児患者数の減少により運営に影響を受けている分娩取扱施設や小児医療の拠点施設に対し支援を実施。＜資料7＞ 安全に無痛分娩を実施できる体制の確保に向け、無痛分娩実施時の急変対応に係る研修の実施に対し補助。 極低出生体重（1,500g未満）児の疾病予防等に有効とされるドナーミルクを利用する医療機関のうち、ドナー登録施設となる医療機関に対し補助。
---	--	---

(5) 医師・看護師確保対策等を推進します		
①基金（地域医療事業） ・地域医療支援センター運営事業 ・女性医師等就労環境改善事業 ・地域医療確保修学資金等貸与事業 ・【新】医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ事業	7,379万円 － (7,300万円) 1億3,791万円 － (1億3,252万円) 1億989万円 － (1億504万円) 1,929万円 － (一)	地域や診療科間のバランスのとれた医師確保を推進するため、地域医療に従事する医師のキャリア形成を支援する地域医療支援センターを運営。 女性医師等の離職防止と定着を図るため勤務環境の改善や復職支援への取組みを実施する二次救急告示医療機関及び総合・地域周産期母子医療センターに対し補助。 周産期医療や救急医療などの分野における医師確保を図るため、医学生に対し、貸与後一定期間、これらの分野のうち知事の指定する医療機関で勤務することを返還免除条件とする修学資金を貸与。 国が策定した医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージの一環として、府内医療機関への実態調査・分析を行い、医師確保計画や医師偏在是正プランの策定等を実施。
②基金（保健医療計画事業） ・医療勤務環境改善支援センター運営事業 ・勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業	4,354万円 － (4,354万円) 38億2,051万円 － (33億4,732万円)	医療従事者の勤務環境改善を促進するため、医療勤務環境改善支援センターを委託により設置・運営。 医師の時間外労働に上限規制が適用されたことをふまえ、医師労働時間短縮計画を策定し、労働時間の短縮に取り組む医療機関に対し補助。
③医師確保計画推進事業費	1億6,410万円 － (1億6,972万円)	地域の実情に応じたきめ細やかな医師偏在対策を推進するため、国から権限移譲された臨床研修病院のプログラム審査その他指定に関する審査を実施。また、医師の勤務環境改善に向け、遠隔ICU体制等を整備する医療機関に対し補助。

④専門医認定支援事業費	539万円 － (544万円)	地域医療に配慮した専門医養成プログラムの作成を行う医療機関に対し補助。
⑤基金（看護事業）		
・病院内保育所運営費補助事業	3億5,894万円 － (2億3,383万円)	看護師等の離職防止と定着を図るため、病院内保育所を設置する病院等に対し補助。
・看護師等養成所運営費補助事業	8億8,491万円 － (8億1,270万円)	看護師等の養成を確保するとともに、教育内容の充実を図るため、養成所の運営に対し補助。
・看護師等人材確保促進事業（ナースセンター事業）	5,695万円 － (5,695万円)	潜在看護師等の活用に向けた復職支援の充実や再就業研修の実施等、看護師等確保対策を推進するとともに、早期離職防止をはかるため、求人施設や求職者への支援を強化。
・【一部新】地域で活躍する看護職員等の確保推進事業（地域包括的感染症対策ネットワーク）	5,931万円 － (4,492万円)	保健所、地域の中核的医療機関、関係団体等を中心とした地域包括的感染症対策ネットワークを構築し、人材の育成等を行うとともに、育成した人材等と協働し、医療・福祉関係施設等での感染症への対応力向上を推進。 また、感染管理の専門医療従事者を育成するため、新たに感染管理認定看護師教育機関の運営に要する費用を助成。
⑥看護師等人材確保促進事業 ・ナースセンター事業	700万円 － (720万円)	潜在看護師等の活用に向けた復職支援の実施等、看護師等確保対策を推進。
(6) 疾患を持つ方々の治療やQOLを向上します		
①難病対策費	157億6,277万円 － (144億4,668万円)	○指定難病医療費援助事業 発病の機構が明らかでなく治療方法が確立していない希少な病気であって、長期の療養を要する難病のうち、厚生労働大臣が指定する指定難病（348疾病）について、その治療費を助成。

		○難病相談支援センター事業 難病患者・家族の生活面を支援するため「大阪難病相談支援センター」において相談事業や交流会を実施。
② 【拡充】臓器移植推進事業費	1,484万円 － (1,268万円)	臓器提供事例が増加傾向にある中、移植医療の適正な実施に資するため、臓器移植コーディネーターを増員するとともに、普及啓発を実施。
③ アレルギー疾患対策事業費	260万円 － (252万円)	大阪府アレルギー疾患対策連絡会議を設置し、府における診療連携体制の在り方の検討を行うとともに、アレルギー疾患医療拠点病院において、医療従事者向けの研修並びに府民への啓発事業等を実施。
④ 不妊・不育症対策事業費	2,494万円 － (2,081万円)	○不育症検査費助成事業 不育症患者の経済的負担を軽減するため、不育症検査に要する費用を助成。 ○性と健康の相談センター事業 不妊・不育症に悩む夫婦等に対する専門的な相談及び情報提供を行う体制を整備し、身体的、精神的負担の軽減と出産への支援を行うとともに、性・生殖に関する相談窓口を設け、正しい知識の普及を実施。
⑤ ハンセン病療養所入所者等支援事業費	1,960万円 － (1,811万円)	ハンセン病回復者の社会復帰及び在宅の回復者やその家族支援のため、社会生活支援を行うコーディネーターの設置及びハンセン病療養所入所者の里帰り等を実施。 また、ハンセン病回復者等に対する偏見や差別の解消のための啓発を実施。
⑥ 先天性代謝異常等検査事業	2億4,768万円 － (2億4,931万円)	○先天性代謝異常等検査事業 20疾患を対象に、早期発見により適切な治療につなげるため、公費負担のもと、新生児を対象としたマススクリーニング検査を実施。 ○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業

⑦【拡充】早発卵巣不全患者等妊よう性温存治療助成試行事業	5,428万円 － (3,492万円)	マスククリーニング検査の対象疾患の追加を検討するために行う国の実証事業に参画し、現在、公費負担による検査の対象外である重症複合免疫不全症（SCID）及び脊髄性筋萎縮症（SMA）に対する検査費用を補助。 ○プレコンセプションケア啓発事業 プレコンセプションケアの普及啓発を実施。 ○早発卵巣不全患者等妊よう性温存治療助成試行事業 妊娠や出産に向けた健康管理等に関する講座を実施するとともに、卵巣予備能を測定するための検査費を補助するほか、卵巣予備能が低下している方に対し、卵子凍結等に係る費用を助成。新たに凍結卵子の保管及び凍結卵子を使用する生殖補助医療に係る費用も助成。
(7) 依存症対策を推進します ①【拡充】依存症対策強化事業費 ・（仮称）大阪依存症対策センター設置準備事業 ②ギャンブル等依存症対策基金事業費	5,702万円 － (8,519万円) 5億537万円 － (4,792万円) 513万円 － (512万円)	第3期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画等に基づき、予防・普及啓発や相談支援体制・治療体制・切れ目のない回復支援体制の強化、大阪独自の支援体制、調査・分析及び人材養成にかかる取組みを推進。＜資料3＞ （仮称）大阪依存症対策センターの開設に向けて、機能の具体化や施設整備の企画検討を推進。（仮称）大阪依存症対策センターの開設に向けて、基本構想・計画の作成を行うとともに、運営に必要な人材確保・養成やデジタルを活用した依存症対策総合戦略の検討等を実施。＜資料3＞ ギャンブル等依存症対策の取組みを持続的に推進していくための寄付金を「ギャンブル等依存症対策基金」に積み立てるとともに、民間団体等によるギャンブル等依存症対策の取組みを支援する助成事業を実施。

(8) 自殺対策を推進します ① 自殺対策強化事業費	1億4,461万円 － (1億3,778万円)	「大阪府自殺対策計画」に基づき、普及啓発、相談支援、人材育成、市町村・関係機関・民間団体等との連携強化などに重点的に取組み、自殺対策を総合的かつ効果的に推進。
(9) 母子保健の強化を推進します ①子ども・子育て支援事業費 ②児童虐待発生予防対策事業費 ③入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業	5億6,281万円 － (3億9,794万円) 1,045万円 － (811万円) 1,000万円 － (1,000万円)	市町村が実施する、乳児のいる家庭や妊婦等に対する相談対応に加え、退院直後の母子に対する心身のケアや育児サポート等に要する経費に対し補助。 ○児童虐待の未然防止のための妊娠・出産対策事業 思いがけない妊娠等、妊娠の悩みを解消するため、電話やメールによる相談窓口「にんしんSOS」を運営し、必要な情報提供や継続的な支援につなげる取組みを実施。 こどもや家族が安心して入院することができるよう、簡易ベッド購入等、入院中のこどもに付き添う家族の環境改善を行う医療機関に対し補助。
2. 健康寿命の延伸と保健 ガバナンスの強化 (1) 健康寿命延伸の取組みを 推進します ①健康寿命延伸プロジェクト 事業費	3,316万円 － (6,651万円)	○オール大阪による健康づくり推進事業 オール大阪で健康づくりの気運醸成を図るため、「健活10」の普及・実践を促進。また、健活おおさか推進府民会議での活動の共有等、産学官の多様な主体との連携による健康づくり活動を展開。 ○若い世代の健康づくり推進事業 若者のヘルスリテラシーの向上を図るため、大学と連携し、大学職員向けの情報交

		換会や学生向けの啓発資材の提供を通じて健康キャンパスづくり・女性の健康づくりを推進。 ○職域の健康づくり推進事業 健康経営の普及を通じた職域での健康づくりの推進を図るため、健康経営優良法人認定取得や従業員の健康に関するオンラインセミナーを開催。 ○健康格差の解決プログラム促進事業 市町村及び職域等と連携し、特定健診及び特定保健指導の実施率向上やフレイル予防に向けた事業を実施。
② 健康増進事業費	3億8,386万円 — (3億4,330万円)	○健康増進事業 市町村が実施する健康増進事業に要する経費に対し補助。 ○地域・職域連携推進事業 地域保健と職域保健の連携を推進し、行政・医療保険者等の関係機関による「地域・職域連携推進協議会」を運営。
③健康・栄養対策費	1,745万円 — (1,856万円)	○健康・栄養対策費 「第4次大阪府食育推進計画」に基づく食育を推進するため、市町村や地域の関係団体等が連携・協働し、地域の特性に応じた取組みを実施。 また、若い世代が健康的な食生活を実践しやすい環境づくりや高齢者の適切な栄養管理に対応するため、配食事業者や市町村等と連携した食環境の整備・情報発信を実施。 ○自然に健康になれる持続可能な食環境づくり事業 「朝食」・「野菜」・「食塩」等の課題解決に向けた取組みをオール大阪で一体的に実施。健康無関心層を含め、行動変容につながるよう、ナッジを活用した「自然に健康になれる持続可能な食環境づくり」を産学官等が連携して推進。

④口腔保健対策費	8,004万円 － (7,855万円)	○大阪府歯科口腔保健計画推進事業 「第3次大阪府歯科口腔保健計画」に基づく歯と口の健康づくりを推進するため、歯科保健の状況調査や評価、普及啓発及び研修を実施するとともに、庁内に設置した口腔保健支援センターにおいて、市町村支援等を実施。 ○障がい者歯科診療体制整備事業 障がい者の拠点施設として障がい者歯科診療センターを大阪市とともに運営。また、障がい者歯科診療を行う医療機関に対する人件費補助を実施。
⑤基金（歯科保健事業） ・医科歯科連携体制確保事業 ・在宅高齢者の歯と口の健康向上推進事業	4,468万円 － (4,468万円) 606万円 － (606万円)	周術期等の入院中患者への継続的な口腔機能管理体制確保のため、歯科医師・歯科衛生士を派遣し、研修や専門的助言を通じて、地域病院での人材育成や歯科診療所との連携を推進。 適切に口腔に関する介護サービスを導入するために、介護サービス計画書（ケアプラン）を作成する介護支援専門員（ケアマネジャー）が歯科に関する知識を習得することで要介護高齢者のQOL向上、誤嚥性肺炎などの全身疾患の予防、全身の健康状態の維持・向上を図る研修の実施に対し補助。
⑥たばこ対策推進事業費	1億22万円 － (1億4,012万円)	健康増進法及び府受動喫煙防止条例に基づく府民・事業者への周知啓発等を実施するとともに、規制対象となる施設等に対して指導監視を実施。 また、受動喫煙防止対策を推進していくことで路上等での喫煙が増加する懸念があることから、民間事業者と連携し、公衆喫煙所の整備にかかる費用の一部を補助。
⑦大阪がん循環器病予防センター事業費	1億9,876万円 － (5,735万円)	○がん検診精度管理事業 市町村のがん検診事業を分析・評価のうえ、課題を明確化するとともに、改善方策等について指導・助言を行う「精度管理センター」を設置・運営。

		○大阪がん循環器病予防センターの老朽化した機械設備を計画的な改修を実施。
⑧循環器疾患予防研究事業費	3,266万円 － (3,266万円)	○循環器病疾患予防研究事業 循環器病疾患の予防のため、健診によるデータ集積、健康づくりノウハウの開発、レセプト・特定健診等のデータ分析を実施。
⑨基金（生活習慣病事業） ・小児期からの生活習慣病等 対策事業	525万円 － (525万円)	ライフコースアプローチの観点から、家族性高コレステロール血症など小児期から配慮が必要な疾患について、早期発見・介入に向けた取組みや小児生活習慣病予防事業を実施。
⑩【一部新】健康づくり支援 プラットフォーム整備等事 業費	5億1,674万円 － (3億2,250万円)	府民の自発的な行動を促進するとともに、健康記録を可視化し、行動変容につなげる大阪府の健康アプリ「アスマイル」について、機能を見直し、より使いやすいアプリを構築。＜資料4＞
(2) がん対策を推進します		
①がん対策推進事業費	1億8,390万円 － (1億7,757万円)	「大阪府がん対策推進条例」及び「第4期大阪府がん対策推進計画」に基づき、がん検診・医療の充実等、がん対策を総合的に推進。 ○組織型検診体制推進事業 がん検診の精度向上を図るため、市町村のがん検診の情報を集約するとともに、分析・検証し、市町村へ提供。 ○がん診療連携拠点病院機能強化事業 地域におけるがん医療の水準を向上するため、がん診療連携拠点病院による患者への相談支援、医療機関相互の診療連携及び緩和ケア等に関する研修等の取組みに対し補助。 ○地域統括相談支援センターモデル事業 がん患者・家族らのがんに関する相談をワンストップで提供する「地域統括相談支援センター」をモデル的に設置・運営するとともに、ピアサポーターを養成するため

		の研修等を実施。
②がん対策基金事業費	3,123万円 － (4,009万円)	「大阪府がん対策基金」を活用し、がんについての正しい知識の普及啓発やがん検診の受診促進、がん教育、小児・AYA世代のがん患者の支援など、がん対策の推進に資する事業を実施。
③基金（がん対策事業）		
・がん医療提供体制等充実強化事業	8,524万円 － (8,524万円)	がん医療提供体制の充実強化を図るため、がん診療拠点病院等が行う施設・設備整備に対し補助。
・緩和医療の普及促進等事業	1,193万円 － (1,293万円)	緩和医療の普及啓発活動、緩和医療研修の実施に対し補助。
・小児がん治療経験者長期フォローアップ支援事業	304万円 － (592万円)	小児がん経験者の二次がんの早期発見につなげるため、適切な検診を受診することができるよう体制を整備。
④重粒子線がん治療患者支援事業費	445万円 － (435万円)	○重粒子線治療利子補給事業 重粒子線がん治療を受ける府民が経済的な事情で治療を断念することがないように、金融機関と連携し利子補給を実施。 ○小児がん患者重粒子線治療助成事業 小児がん患者（15歳未満）が、重粒子線がん治療を受けられるよう、公的医療保険の対象とならない治療費の負担を軽減するため、大阪重粒子線センターでの治療費に対し補助。
⑤妊よう性温存治療費助成事業費	5,106万円 － (4,700万円)	がん治療を受けながら、将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者に対し、がん治療に際して行う妊よう性や生殖機能の温存治療及び温存後生殖補助医療にかかる費用を助成。

(3) 肝炎対策を推進します ①肝がん・重度肝硬変医療費援助事業費 ②肝炎医療費援助事業費 ③肝炎ウイルス検査事業費 ④肝炎肝がん総合対策事業費	1,346万円 － (1,567万円) 3億8,612万円 － (4億3,056万円) 4,750万円 － (4,717万円) 2,087万円 － (1,952万円)	国の治療研究事業として肝がん・重度肝硬変の入院医療費及び肝がんの通院医療費が高額療養費の限度額を一定の期間超えた場合等に高額療養費の限度額を超えた月の医療費を助成。 B型及びC型肝炎患者のインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成。 肝炎ウイルス陽性者を早期に発見し、治療につなげるため、府内医療機関における無料の肝炎検査を実施。 また、肝炎検査陽性者の初回精密検査に加え、定期検査にかかる費用を助成。 肝炎患者・家族及び地域の医療機関等への肝疾患にかかる情報提供・相談支援や医療従事者を対象とした研修を開催する肝疾患診療連携拠点病院に対し補助。 また、肝炎医療コーディネーターを養成するなど、肝炎・肝がんに関する正しい知識の普及や肝炎検査陽性者のフォローアップを実施。
(4) 医療保険制度を安定的に運営します ①国民健康保険基盤安定事業費負担金 ②国民健康保険特別会計繰出金 ・都道府県繰出金	401億7,875万円 － (415億5,956万円) 450億6,272万円 － (435億5,013万円)	市町村国保が行う、保険料負担が難しい低所得者への保険料軽減措置等に対し負担。 府が保険者として行う事業を運営するために必要な経費を国民健康保険特別会計に繰出。 保険給付費等の9%相当を負担。

・高額医療費繰出金	65億2,308万円 － (74億7,494万円)	高額な医療費の発生による財政への影響を緩和するため、レセプト1件当たり90万円を超える部分について負担。
・特定健診・特定保健指導 公費負担事業繰出金	7億6,357万円 － (7億9,339万円)	医療保険者に法律で実施が義務付けられた特定健診・特定保健指導に要した経費の一部を負担。
③後期高齢者医療給付費負担金	1,172億7,497万円 － (1,113億7,225万円)	大阪府後期高齢者医療広域連合に対し、療養の給付等の後期高齢者医療給付額の一部を負担。
④後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金	248億5,357万円 － (233億8,060万円)	市町村に対し、保険料負担が困難な低所得者等への保険料軽減額の一部を負担。
⑤後期高齢者医療高額医療費負担金	131億9,252万円 － (113億7,286万円)	大阪府後期高齢者医療広域連合に対し、高額な医療費の発生による財政への急激な影響を緩和するため、レセプト1件当たり80万円を超える部分の一部を負担。
3. 日常生活を支える公衆衛生の向上		
(1) 薬事対策を推進します		
①麻薬等取締・乱用防止対策事業費	1,132万円 － (1,013万円)	○危険ドラッグ対策事業 「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、国に先駆けて危険ドラッグ成分を知事指定薬物に指定し、効果的な監視・指導を実施。 ○覚せい剤等乱用防止対策事業 「大阪薬物乱用防止第六次戦略」に基づき薬物乱用防止指導員や各関係機関等と協力して薬物乱用防止の啓発活動を実施。
②後発医薬品安心使用促進事業費	889万円 － (914万円)	後発医薬品安心使用促進のための協議会の開催や地域フォーミュラりの取組の支援、医療関係者等への情報発信を実施。

③治験環境整備促進事業	201万円 － (201万円)	府内の分散型治験環境を整備するため、関係者会議及び実施医療機関と協力機関等との連携会議の開催、府民への啓発等を実施。
④基金（医療従事者確保事業） ・薬剤師確保事業	287万円 － (287万円)	病院薬剤師の確保を図るため、大学等と連携し病院薬剤師の職能や魅力、キャリア形成等に関する情報を薬学生等に直接的に発信する大阪府病院薬剤師会の取組に対し補助。
(2) 食の安全安心を推進します		
①食の安全安心推進事業費	993万円 － (782万円)	「大阪府食の安全安心推進条例」の基本理念に基づき、府民の健康保護のために、危機管理対策の強化、食品衛生の知識の普及などの施策を実施。
②食肉衛生検査所運営費	2,054万円 － (1,917万円)	羽曳野食肉衛生検査所において、と畜検査、BSEスクリーニング検査及び衛生管理指導を実施。
(3) 生活衛生の確保を推進します		
①国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業認定指導事務費	69万円 － (57万円)	国家戦略特別区域法に規定する外国人向けの滞在施設として申請のあった事業者に対する審査、認定及び認定施設に対する指導・苦情などに伴う立入検査を実施。
②住宅宿泊事業届出指導事務費	82万円 － (71万円)	住宅宿泊事業法に基づき事業者から届出のあった施設に対する審査、設備基準等の確認や指導・苦情などに伴う立入検査を実施。
③【拡充】宿泊サービス向上等事業	2,581万円 － (2,508万円)	民泊事業者等を対象に衛生管理等の向上のための講習会を開催するとともに、外国人観光客の宿泊マナー向上を図る動画等を活用し、デジタルサイネージ等の放映期間等の拡充を図り周知啓発を実施。
(4) 水道事業の広域連携を推進します		

① 水道基盤強化に向けた広域化推進事業費	157万円 — (157万円)	府と府内の全水道事業者等を構成員とする府域一水道に向けた水道のあり方協議会において検討・協議を実施。
(5) その他		
① 保健所施設設備改修事業費	7,586万円 — (4億2,095万円)	保健所の施設を維持するため、老朽化した施設を計画的に改修するとともに必要な備品を更新。
② 池田保健所移転建替整備事業費	6億2,763万円 — (4,809万円)	池田保健所の移転建替整備に向けた用地取得、建築工事等を実施。
③ 【拡充】許認可・指導検査等業務DX推進事業費	2億892万円 — (5,633万円)	医療機関や福祉施設等の検査や許認可業務のDXを推進する「許認可・検査等業務DXプラットフォーム」を福祉部と共同で構築し、運用開始。また、環境衛生・薬事・食品衛生分野の許認可業務等への拡張に向けた機能構築を実施。
4. 安全安心に向けた医療基盤の整備		
(1) 災害対応機能を強化します		
① 保健所等災害対応力強化事業費	2,640万円 — (4,078万円)	災害時、迅速かつ効果的に支援活動を実施できるよう府保健所に自家発電設備を整備。
② 災害時医療体制整備事業費 ・大阪DMAT整備事業	1,764万円 — (1,958万円)	災害拠点病院の医師、看護師等に対し、実際の災害現場における活動を踏まえた研修・訓練を実施。また、国開催の大規模地震時医療活動訓練参加にかかる費用に対し補助。
・【拡充】災害医療機関施設整備事業	21億7,663万円 — (17億3,100万円)	災害に備えるため、耐震化及び非常用設備導入等を行う災害医療機関の施設整備に対し補助。特に、非常用自家発電設備の新規設置について、補助率を引き上げ、支援を促進。

・NBC災害・テロ対策設備整備事業	2,000万円 － (2,000万円)	放射性物質、化学剤、生物剤による災害・テロに備え、災害拠点病院が行う防護服や除染設備等の整備に対し補助。
・災害医療機関設備整備等事業	4,747万円 － (2,067万円)	○ 耐震診断費補助 災害発生時、病院での病院機能の維持の必要性が再認識されたことから、既存建物の耐震診断を促進するため、未診断の救急告示病院の耐震診断費用に対し補助。 ○ 災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業（災害支援ナース） 「災害・感染症医療業務従事者」のうち災害支援ナースの派遣に係る派遣用資機材等の購入経費を補助。
③ 医療施設等整備費補助金 （在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業）	170万円 － (170万円)	人工呼吸器使用者に対して訪問診療を実施している医療機関における停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等の整備に対し補助。
④ 基金（地域医療事業） ・在宅医療サービス基盤整備推進事業	2,417万円 － (7,123万円)	「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」において災害時等に自院のかかりつけ患者以外にも貸し出せる簡易自家発電装置の整備を補助。
⑤ 基金（看護事業） ・在宅患者災害時支援対策整備事業	720万円 － (683万円)	災害時における在宅人工呼吸器装着患者に対し非常用電源の確保や支援体制強化のため、非常用充電設備の新規設置やメンテナンス・普及活動等に対し補助。
⑥ 基金（救急医療事業） ・災害医療体制確保充実事業	4,819万円 － (4,433万円)	○災害医療研修事業 南海トラフ地震等の大規模災害に備え、災害医療基礎研修や災害医療コーディネーター研修を実施。 ○BCP策定支援事業 近年多発する自然災害を踏まえ、耐震や

		浸水対策等の各種災害への備えを講じ、府の災害医療体制を強固なものとするため、救急告示病院が行うBCP策定及び策定後の見直しに対し補助。 ○DMAT等対応力向上事業 災害時における病院の機能維持や被災地域内での医療活動を円滑に行うための知識・技能を習得する研修を実施。
⑦ 基金（疾病対策事業） ・ 発災時の難病患者に対する支援体制構築事業	796万円 － (971万円)	発災時に、在宅で人工呼吸器を使用している難病患者に適切な支援が行えるよう、医療機関に対する研修を実施。
・ 災害時における難病患者ひなんサポーター育成事業	450万円 － (147万円)	発災後に、在宅避難をしている難病患者の状況確認等が必要な場合に備え、難病患者ひなんサポーターの育成を実施。
⑧ 基金（母子保健事業） ・ 災害時小児・周産期医療体制確保事業	153万円 － (153万円)	災害時に本府に参集する災害時小児周産期リエゾンに対する技能訓練等を実施。
⑨ 【一部新】大規模地震時災害対応力強化事業費	1億139万円 － (1億770万円)	大規模地震発生時に医療機関の災害対応力を強化するため、新たに災害医療協力病院の訓練実施支援や災害拠点病院のネットワーク強化などを実施。
⑩ 災害時歯科保健医療提供体制整備事業	5,704万円 － (1,900万円)	災害時において適切な歯科保健医療提供体制を確保できるよう、必要な体制整備の実施に対し補助。
⑪ 基金（医療従事者確保事業） ・ 災害薬事コーディネーター養成研修	736万円 － (533万円)	災害時に、府内各地域において、保健所や市町村等と連携し医薬品確保・供給調整を行う災害薬事コーディネーターを養成し、災害薬事体制を整備。
⑫ 災害時医薬品等確保供給体制整備事業費	300万円 － (300万円)	「大阪府地域防災計画」に基づき災害時医療体制整備の一環として、災害時に必要な医薬品・医療用資材等の確保供給体制を整備。

(2) 感染症対策を強化します ①【一部新】新型インフルエンザ等対策費 ②感染症予防対策費 ③エイズ・梅毒予防対策費 ④結核対策関連事業費 ⑤先天性風しん症候群対策費	19億9,937万円 — (4億7,522万円) 3億2,528万円 — (4億9,955万円) 5,127万円 — (5,082万円) 1億5,131万円 — (1億4,209万円) 1億323万円 — (1億590万円)	幅広い呼吸器感染症等の発生等に備え医療機関等に対する訓練・研修等の拡充や、新たに協定締結医療機関に対し協定更新のための意向確認を実施するとともに、設備整備補助による医療提供体制の整備を促進。また、府民等への啓発や備蓄計画に基づいた個人防護具や抗インフルエンザ薬備蓄等を実施。 感染症に迅速・的確に対応するため、感染拡大防止や医療体制確保、人材養成・知識の普及、予防啓発など、総合的な対策のほか、HPVワクチン接種の積極的勧奨再開に伴う相談体制の強化を推進。また、観光客向けの多言語での感染症予防啓発等を実施。 HIV・エイズに関する正しい知識の普及啓発、相談指導・検査体制の確保など、総合的なエイズ対策を推進。 また、梅毒について、検査機会を設けるとともに、若年層や感染者報告数の多い層を中心とした啓発を実施。 結核患者の早期発見、まん延防止のため、定期健診、患者管理検診及び接触者健診を実施するとともに結核患者の医療費を負担。また、結核に関する正しい知識の普及啓発や結核予防従事者に対する研修等を実施。 先天性風しん症候群の発生を防止するため、医療機関における無料の風しん抗体検査及びワクチン接種費用を助成する市町村に対する補助を実施するとともに、風しん予防に関する啓発を実施。
(3) 外国人への適切な医療等を提供します ①外国人医療体制整備事業費	2,918万円 — (5,216万円)	○地域における外国人医療対策協議会設置等事業 外国人に対する適切な医療を確保するため、医療、観光等の関係者が実態に応じた

		取組みについて協議・検討するとともに、を府内の外国人患者受入れ可能な医療機関の受入れ体制の実態調査を実施。 ○トラブル相談窓口設置事業 医療費未払いや未収金回収をはじめ、さまざまな相談に対応するトラブル相談窓口を国と連携して24時間365日体制で設置・運営。 ○外国人患者受入れ研修事業 外国人患者対応の専門家等の意見を取り入れた外国人患者受入れ研修を実施し、外国人患者受入れ医療機関の対応力向上を図る。 ○外国人患者受入れ医療機関における患者受入れ環境整備事業 外国人患者受入れの障壁となる医療費未収金リスク低減のため、保険・保証サービスや研修、キャッシュレス化及び外国人患者向けの情報発信に係る費用を補助。 ○海外旅行保険の加入勧奨事業 来阪中の外国人観光客に対し、効果的な海外旅行保険の加入勧奨を実施。
(4) 万博後の大阪の未来に向けて取り組みます ①【拡充】新技術活用型医療システム構築促進事業 ②【新】医療分野における生産性向上に対する支援	6,000万円 － (1,000万円) 21億3,000万円 － (一)	医療従事者の負担軽減等に資する生成AIシステム等の府域展開を加速させるため、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が実施する新技術を活用した研究事業における連携医療機関拡充にかかる費用及び医療機関におけるAI技術の導入にかかる費用を補助。 少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴う人手不足に対応するため、業務効率化や職場環境改善に資するICT機器等の導入・活用などの生産性向上に取り組む病院に対し補助。＜資料7＞

③【一部新】外国人材共生に向けた医療機関整備等事業	3,020万円 － (2,443万円)	○【新】外国人材共生に向けた医療機関整備事業 グローバル人材の集積を目指す大阪において、外国人材が安心して過ごせるよう、府内モデル地区内の医療機関における外国人患者対応力を向上させるための研修を実施。 ○外国人医療体制情報発信事業 「おおさかメディカルネット」を通じて医療機関や外国人等を対象に医療情報等を発信 ○【拡充】外国人医療情報整備事業 「おおさかメディカルネット」の周知に加えて、府内医療機関において需要が増加しているネパール語に対応するためのサイト改修を実施。 ○【拡充】多言語遠隔医療通訳拡充事業 外国人患者受入れに際し、円滑なコミュニケーションを図るため、電話及びビデオによる9か国語（令和8年度よりネパール語を追加）対応の医療通訳遠隔サービスを実施。
④【拡充】新型インフルエンザ等対策費	4,096万円 － (1,803万円)	○リスク評価ネットワーク体制構築事業 感染症に関する様々な情報を収集・分析し、リスク評価を行うため、大阪健康安全基盤研究所に設置している健康危機管理監を中心に、府と大学・研究機関等のネットワーク体制を構築。また、新たにリスク評価会議や、リスク評価に係る初動体制を確認するため関係機関と連携した訓練等を実施。＜資料5＞ ○下水サーベイランス研究推進事業 疾患サーベイランスを補完し、リスク評価の有効な指標として活用できるよう、感染症の流行予測や流入探知技術の確立に向けて大阪健康安全基盤研究所及び大阪公立大学での下水サーベイランス研究を推進。令和8年度からは大阪市内3か所及び東大阪エリア、関西空港で採水・検査を実施。＜資料5＞

⑤健康寿命延伸プロジェクト事業費 ・【新】市町村健康寿命延伸にかかる共創創出支援事業 ・【新】万博レガシーを継承した健活10プロモーション	3,363万円 － (一) 1億4,080万円 － (一)	万博出展企業等が保有するヘルスケア技術やノウハウ等を最大限活用し、市町村ごとの健康課題に応じて、企業とのマッチングから実証事業の実施、市町村の事業化までを支援。＜資料4＞ おおさか健活大使を任命し、けんしん受診率向上に向けて、主に無関心層をターゲットに、特定健診・がん検診をあわせて啓発。また、万博自治体催事等の成果を「万博レガシー」として継承し、「健活10ソング&ダンス」・「おおさかEXPOヘルシーメニュー」を核としたプロモーション事業を実施。＜資料4＞
⑥【新】水道広域化DX推進補助事業	3,000万円 － (一)	大阪広域水道企業団が広域的に行う人工衛星画像やAIによる漏水調査等の取組に補助を実施し、水道事業の広域化・耐震化を促進。
⑦【拡充】治験環境整備活用促進事業費	2,700万円 － (860万円)	府内の分散型治験環境のネットワークを活用した治験促進を図るとともに、新たに国際共同治験の支援体制を整備することにより、製薬企業の創薬の活性化や再生医療製品等の実用化を推進。
5. 大阪健康安全基盤研究所にかかる運営費交付金等 ① 大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 ② 大阪健康安全基盤研究所施設整備費補助金 ③ 旧大阪府立成人病センター管理費	18億372万円 － (16億597万円) 1億9,456万円 － (11億8,924万円) 2,126万円 － (2,787万円)	大阪健康安全基盤研究所における調査研究、試験検査、情報収集・解析等の業務に要する運営費を交付。 旧大阪健康安全基盤研究所森ノ宮センター等の撤去、跡地の管理等を実施。 旧府立成人病センター跡地等の管理を実施。

6. 大阪府立病院機構にかかる負担金、貸付金等 ① 大阪府立病院機構運営費負担金 ・【拡充】運営費負担金 ・経営改善強化支援事業 ② 【拡充】大阪府立病院機構建設改良資金貸付金 ③ 大阪府立病院機構職員共済公的負担金 ④ 地方独立行政法人大阪府立病院機構移行前地方債償還費公債管理特別会計繰出金 ⑤ 大阪はびきの医療センター整備事業費	126億6,969万円 － (90億7,651万円) 1億6,500万円 － (1億9,800万円) 25億5,000万円 － (21億8,227万円) 19億2,513万円 － (19億4,978万円) 413万円 － (3,177万円) 8億6,599万円 － (2,388万円)	5病院を運営する地方独立行政法人大阪府立病院機構（以下「府立病院機構」）に対し、物価・人件費の高騰等を踏まえた運営費負担金を交付。＜資料6＞ 府立病院機構が持続的な運営を継続できるよう、経営改善方策を検討し、その実現に向けた伴走支援を実施。＜資料6＞ 府立病院機構に対し、医療機器の更新や施設の改修に要する資金を貸付。令和8年度は、大阪母子医療センター新病院整備事業の入札不調を受け、老朽化している高度医療機器の更新費用を緊急的に増額。＜資料6＞ 府立病院機構職員にかかる基礎年金拠出金等の納付に要する費用のうち、法令に基づく部分（公的負担分）を負担。 府立病院機構の病院事業にかかる地方債を国等に償還するため、元利償還金を一般会計に一旦収入した後、公債管理特別会計に繰出。 大阪はびきの医療センターの旧施設撤去に要する費用の一部について貸付等を実施。
--	--	--

(国民健康保険特別会計)

事業名	R 8 既内示額 R 8 復活要求額 (R 7 当初額)	摘 要
①保険給付費等交付金		
・保険給付費等交付金（普通交付金）	5,941億5,125万円 － (5,941億5,125万円)	市町村による療養の給付等の支給に要する費用等に応じ、普通交付金を交付。
・保険給付費等交付金（特別交付金）	59億9,468万円 － (59億6,868万円)	市町村の財政状況その他の事情に応じ、特別交付金を交付。
②介護納付金・前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等	1,504億3,824万円 － (1,504億3,824万円)	介護納付金、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等を社会保険診療報酬支払基金に対し納付。
③保健事業費		
・国民健康保険ヘルスアップ支援事業費	1億3,454万円 － (1億4,733万円)	府内市町村の健康課題や保健事業の実施状況を把握するとともに、市町村における保健事業の推進を支援。
・地域と医師会との連携強化事業	1,000万円 － (1,000万円)	特定健診受診率・特定保健指導実施率の向上のため、市町村保健事業の地区医師会(医療機関)の実施状況や市町村との連携状況を把握するとともに連携強化のための支援を実施。
・【一部新】健康づくり支援プラットフォーム事業費	3億2,134万円 － (2億4,734万円)	国保被保険者にかかる「健康づくり支援プラットフォーム整備等事業（アスマイル）」を実施。

令和8年2月定例府議会提出予定議案の概要

(健康医療部)

1. 事件議決案（2件）

	件名	概要
1	地方独立行政法人大阪府立病院機構に係る第5期中期計画について認可する件	地方独立行政法人大阪府立病院機構が作成する第5期中期計画について認可するため、地方独立行政法人法第83条第3項の規定により議決を求めるもの。
2	大阪府立救命救急センターの診療料等に関する債権放棄の件	大阪府立救命救急センターの診療料等の債務者に対して、大阪府が有する債権を放棄することについて議決を求めるもの。 件数 31件 金額 回収不能となった822万1,821円 及び当該診療料等に係る遅延損害金

2. 条例案（一部改正7件）

	件名	概要
1	大阪府保健所条例一部改正の件	水質基準に関する省令の改正により、水道により供給される水の基準に、新たにPFOS及びPFOAについての基準が追加されたことに伴い、水質検査に係る手数料の額の改正等を行う。 ・飲用水の水質検査に係る手数料 〔改正前〕 198,700円 〔改正後〕 231,200円 等 施行日：令和8年4月1日

	件 名	概 要
2	精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例一部改正の件	職員の給与に関する条例の改正により職員の給料月額が改められたこと等を踏まえ、精神保健指定医が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者が入院を必要とするかどうかの判定等の職務を行う場合の報酬の額を改正する。 〔改正前〕 1 件 1 0, 5 8 0 円 〔改正後〕 1 件 1 0, 9 3 0 円 施行日：公布の日
3	大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例一部改正の件	1 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令により厚生労働大臣が定める基礎財政安定化基金拠出率が見直されることに伴い、大阪府後期高齢者医療広域連合の基礎拠出額に係る割合を10万分の36から10万分の29に改正する。 2 子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率についての規定が追加されたことに伴い、大阪府後期高齢者医療広域連合の子ども・子育て支援納付金拠出額に係る割合を10万分の4とする。 3 大阪府後期高齢者医療広域連合の拠出率を、令和8年度に限り、零とする。 施行日：令和8年4月1日
4	大阪府国民健康保険事業費納付金条例一部改正の件	国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の改正により、子ども・子育て支援納付金納付金基礎額についての規定が追加されたことに伴い、条例において当該額の算定の方法を定める。 施行日：令和8年4月1日
5	大阪府衛生行政事務手数料条例一部改正の件	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正により、規定の整備（条項ずれ是正）を行う。 施行日：令和8年5月1日

	件 名	概 要
6	大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例一部改正の件	1 大阪市内の旧薬種商販売業の施設が廃止されたことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に基づく事務の一部を同市が処理することとしている規定を削除する。 施行日：公布の日 2 医療法の改正により、規定の整備（条項ずれ是正）を行う。 施行日：令和 8 年 4 月 1 日
7	大阪府食品衛生法施行条例一部改正の件	食品衛生法施行規則の改正により、従業者が常駐せず、全自動調理機により調理された食品を販売する飲食店営業についての施設の基準が新設されたことに伴い、条例において同趣旨の改正を行う。 施行日：令和 8 年 4 月 1 日

第3期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画(案)の概要

資料3

ギャンブル等依存症対策推進計画は、ギャンブル等依存症の予防と、早期発見・早期介入により、ギャンブル等依存症の本人やその家族等に対する支援の充実を図り、府民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として作成(第1期計画:R2.3～第2期計画:R5.4～)。国のギャンブル等依存症対策推進計画(R7.3改定)及び基本法の一部改正(R7.9施行)等を踏まえ、今年度中に府独自の取組も含めて第3期計画を策定。

計画期間

- 令和8年4月～令和11年3月(3年間)

全体目標

ギャンブル等依存が 疑われる人等の割合の低減	ギャンブル等依存症は病気であ ることの認知度の割合の増加
2.9% 未満 (令和7年度 2.9%)	90% 以上 (令和7年度 82.6%)

計画(案)の全体像と新規・拡充のポイント

- 相談窓口やギャンブル等依存症対策の取組に関する広報啓発の強化、若年層に向けた予防教育の充実 →重点①②
- 違法オンラインギャンブル等が禁止されている旨の周知徹底 →重点①②
- 相談・医療・回復支援の充実に向けた体制及び関係機関とのネットワーク等の強化 →重点③④⑤⑥
- (仮称)大阪依存症対策センターの開設に向けた準備の加速 →重点⑦
- ギャンブル等依存症に関する調査・分析と医師確保・養成の推進 →重点⑧⑨

I 予防・普及啓発 の強化	【重点①】 発症予防・正しい知識の普及啓 発の強化	■ 各世代への発症予防・普及啓発 ➢ 若年層向けの発信強化、公民連携、ポータルサイトの充実 ■ 違法なオンラインギャンブル等に関する啓発 ➢ SNS、動画等を活用した啓発、学校等での予防教育の推進 ■ 多様な関係機関と連携した啓発月間における普及啓発	拡充 新規
	【重点②】 若年層向け予防教育の強化	■ 児童・生徒や大学・専修学校等への普及啓発 ➢ 学校等での予防教育の推進 ■ 若年層にかかわる機会がある人たちへの普及啓発 ■ 家庭への普及啓発 ➢ PTAの研修会等を通じた保護者への啓発	拡充 拡充
II 相談支援体制 の強化	【重点③】 依存症の本人及びその 家族等への相談支援体制の充実	■ 相談窓口の整備 ➢ 夜間・休日対応や多職種による相談など、相談者のニーズに沿った相談支援 ■ 本人及び家族等への相談支援の充実 ■ 回復支援の充実	拡充
III 治療体制の 強化	【重点④】 治療可能な医療機関の拡充と 治療体制の構築	■ 治療可能な医療機関の充実や専門治療プログラムの普及 ■ 受診したギャンブル等依存症の本人等への支援 ➢ 再発防止に向けた環境支援	拡充
IV 切れ目のない 回復支援体制 の強化	【重点⑤】 関係機関等との協働に よる切れ目のない支援の推進	■ ネットワークの強化 ■ 円滑な地域との連携支援の実施 ➢ OATISを中心とした関係機関との連携強化 ➢ OACの枠組を活用した各機関・団体等との情報交換や課題共有の充実	拡充
V 大阪独自の 支援体制の推進	【重点⑥】 自助グループ・民間団体等の 活動の充実	■ 自助グループ・民間団体等が行う活動への支援と協働	
	【重点⑦】 (仮称)大阪依存症対策 センターの設置準備	■ OATISによる取組みの推進 ■ 「(仮称)大阪依存症対策センター」設置準備 ➢ 令和11年度の開設に向けた基本計画の作成、機能の具体化、人材確保等	新規
VI 調査・分析の推進	【重点⑧】 ギャンブル等依存症に 関する調査・分析の推進	■ ギャンブル等依存症に関する実態調査 ➢ 依存症予防の対策に資する調査・分析を推進 ■ ギャンブル等依存症の本人及びその家族等の実状把握	拡充
VII 人材の養成	【重点⑨】 相談支援等を担う人材の養成	■ 医師確保・養成の推進 ➢ 大学や大阪精神医療センターと連携した医師等の確保・養成 ■ 段階的養成プログラムの実施 ■ 様々な相談窓口等での相談対応力の向上	新規

今後のスケジュール

1月28日～2月26日: パブリックコメント受付

3月末: 計画策定(予定)

(仮称)大阪依存症対策センター設置準備について(概要)

令和11年度の開設に向けて必要な人材養成・確保などを進めるとともに、デジタル社会の熟度やニーズの変化など多様化する最新の社会情勢を踏まえ、基本構想・計画の作成や相談支援・情報発信等の機能の具体化を行う。

センターの機能

【設置場所】交通至便な場所

※R6.12 (仮称)大阪依存症センター機能とりまとめなど

相談・医療・回復 ワンストップ支援

- ・多職種による相談体制
- ・民間支援団体等との連携強化
- ・気軽に必要な支援が受けられる環境整備

調査分析

- ・依存症対策の分析に必要なデータの収集分析

普及啓発・情報発信

- ・予防・早期発見から回復支援までの幅広い啓発・情報発信

人材養成

- ・中核を担う医師の確保
- ・高度医療人材の養成

令和8年度予算内示額

5億537万円

<基本構想・計画、機能企画推進>(新)

(負担割合：府1/2・市1/2)

- ・センターの開設に向けて、各機能等についての検討を踏まえ、施設の基本構想・計画を作成
- ・交通至便な場所における、相談支援や情報発信等の実証実験により、来所者数・属性・情報発信のニーズ等のデータを得て、基本構想・計画の作成に必要な機能(設置場所や需要規模、運営方法等)を検討・分析

試行実施を踏まえて、基本構想・計画に反映

<機能の構築・試行実施>(新)

(負担割合：府1/2・市1/2)

相談支援

- ・非対面相談システムの活用による相談体制の充実・強化を図るため、生成AIを組み込んだ新たなチャットボットシステムやバーチャル・アバター等による相談環境を構築し、試行実施を推進
- ・弁護士等の専門家や民間団体などと、依存症本人・家族をオンラインでつなぐワンストップ相談の試行実施を推進



調査分析

- ・デジタルで相談支援等の記録を収集・蓄積し、データ分析等を行うためのシステム構築に向け、企画検討を実施

情報発信・普及啓発

- ・センターにおける情報発信・普及啓発のあり方やSNSの効果的な活用等、発信方法・内容を検討

人材養成

- ・大学に寄附講座を設置し、予防・早期介入に関する支援プログラムの開発や、センター運営に必要な医師等の確保・養成を推進

<既存事業>(継続)

- ・依存症専門のSNS相談、啓発月間における啓発、依存症ポータルサイト・簡易相談支援アプリの運用等を推進

ロードマップ(予定)

⇒令和11年度のセンター開設をめざして着実に準備を進めていく

	開設前準備	R8	R9	R10	R11	R12
施設整備	開設に向けたハード整備	基本構想・計画候補地選定検討	基本設計 設置場所選定	実施設計・設営工事等	センター開設 (予定)	IR 開業
・相談・医療・回復ワンストップ支援 ・普及啓発・情報発信 ・調査分析 ・人材養成	人材の確保・養成 対面とオンラインによる 予防から回復支援 までの体制構築	各機能に関する企画検討・開発・試行など				

万博で高まった健康気運を途絶えさせることなく、府民の主体的な健康づくりにつなげるため、以下の取組みを実施し、健康寿命の延伸・健康格差の縮小をめざす。

1. 府民の健康増進を図る新規事業〔令和8年度予算内示額 1億7,443万円〕

(1) おおさか健活大使によるけんしん等のPR

目的

40～50歳代(けんしんの対象年齢、疾患リスクが上昇する世代)をターゲット層に、特定健診・がん検診の受診を促進。

内容

大阪にゆかりのある著名人を「おおさか健活大使」に任命。
関係機関協働での周知キャンペーンやweb広告などを行うとともに、大使によるSNSでの発信やイベントへの参画など、幅広い啓発活動を実施。



(2) 万博レガシーを継承した健活10プロモーション



万博を契機に制作した「健活10ソング・ダンス」及び「おおさかEXPOヘルシーメニュー」を核としたプロモーションを展開し、健活10のさらなる普及・定着を図る。

健活10ソング・ダンス

- ・ 府民参加型の大規模イベントで、ダンス動画(PR動画)を撮影
- ・ 大規模イベントに向けた機運醸成(SNS投稿企画等想定)

▼健活10ソング・ダンス キービジュアル



おおさかEXPOヘルシーメニュー

- ・ インフルエンサーと連携した情報発信(レッスン動画の配信等想定)
- ・ 料理体験イベントの開催

＊おおさか健活大使との連携も検討

▼R7年度 大阪・関西万博での実績



R7.7.25 健活10EXPOLIVE!



R7.8.23-24 食のDEMO LIVE in 大阪ヘルシアPV

(3) 市町村と万博出展企業等のマッチングによる健康づくり共創創出支援

目的

府の健康寿命延伸と拡大傾向にある市町村間の健康格差の縮小に向け、地域における健康づくり事業を推進。

内容

万博出展企業等が保有するヘルスケア技術やノウハウ等を最大限活用し、市町村ごとの健康課題に応じて、企業とのマッチングから実証事業の実施、市町村の事業化までを支援。



2. アスマイルのリニューアル〔令和8年度予算内示額 3億2,122万円〕

府民の自発的な行動を促進するとともに、健康記録を可視化し、行動変容につなげる大阪府の健康アプリ「アスマイル」について、機能を見直し、より使いやすいアプリを構築。令和9年2月リリース予定。

▼ 搭載予定機能

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ①メールアドレスによる初期登録不要 | ⇒ ダウンロード後、即利用可能 |
| ②マイナンバーカード認証による本人確認 | ⇒ 簡便性・即時性の実現 |
| ③貯めたポイントでサービス利用 | ⇒ 協賛店との連携強化 |



大阪・関西万博における感染症対応から得られた知見の集積・総括を踏まえ、府新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、次なる感染症危機において迅速かつ的確なリスク評価を実施できる体制の確立に向けた取組を推進する。また、リスク評価に必要な下水サーベイランス研究を推進するため、採水地の拡充や関空での検査を継続し、より広域的な感染症流行状況を把握できる体制の構築を図る。

I リスク評価ネットワーク体制の構築

令和8年度予算内示額 2,244万円

「大阪・関西万博感染症情報解析センター」での知見・総括を踏まえ、引き続き大安研に設置した**健康危機管理監**を中心に、**リスク評価機能の更なる発展**を図る。

①大学・研究機関との連携強化

※CiDER:大阪大学感染症総合教育研究拠点

※OIRCID:大阪公立大学大阪国際感染症研究センター

- 大安研、CiDER※、OIRCID※、府及び市の5者で「**感染症危機事象に備えた連携協力に関する協定**」を令和7年度内を目途に締結し、各機関の役割分担を踏まえ、**リスク評価機能向上に向けた施策を推進**。

②リスク評価体制の試行的運用【新】

- 有事におけるリスク評価体制を整備するため、「**大阪健康安全基盤研究所リスク評価会議(仮称)**」を新たに立ち上げ、平時より**感染症情報を収集・分析し、それに基づくリスク評価を実施**。

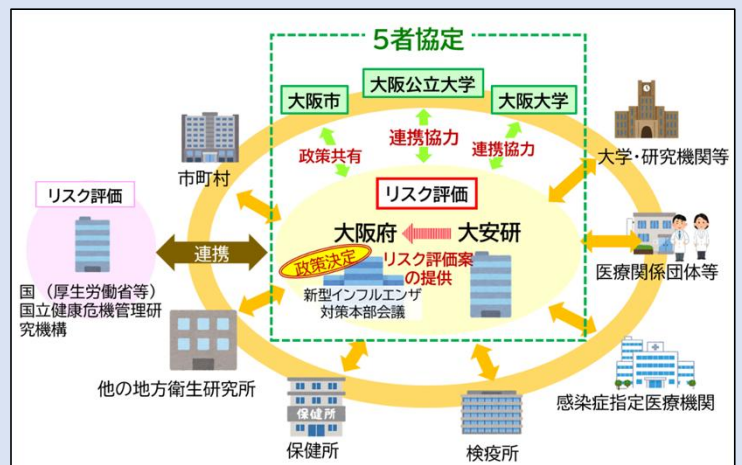
③有事対応を想定した訓練【新】

- ネットワークを活用したリスク評価に係る初動体制を確認するため、**大安研、CiDER、OIRCID等と連携した訓練を実施**。

④ネットワーク構成機関の人材育成

- 公衆衛生医師や保健師、感染管理看護師等に対する研修を実施**。

≪情報収集・分析に係るネットワーク(イメージ)≫



II 下水サーベイランス研究の推進

令和8年度予算内示額 1,852万円

感染症の流行予測等技術確立にむけた研究の推進

大阪・関西万博を契機に輸入感染症をターゲットとした下水サーベイランスの調査手法を確立するため、大安研及び公立大における研究を支援。

令和7年度までの研究の成果

下水検体の有効な処理方法や、一度の検査で複数の病原体遺伝子を効率的に検出するための手法等を確立。

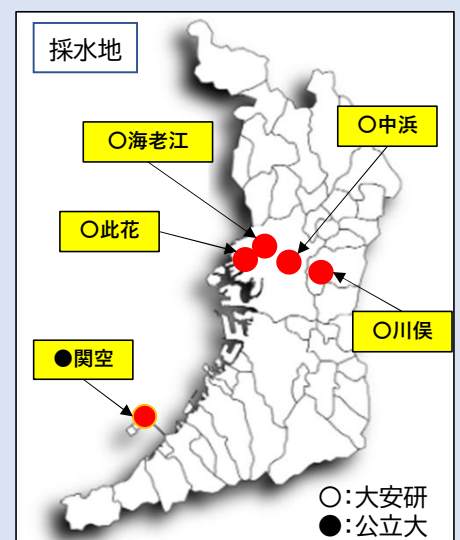
(課題) 検出結果と患者報告との相関が安定しないため、引き続きデータ収集・分析を行い、**解析方法の検証が必要**である。

令和8年度取組

大安研:採水地※を大阪市内2か所(此花・新舞洲)から、右図のエリアに広げる。
公立大:関空での検査を継続。

※下水処理場等

感染症の流行予測や、下水中の病原体遺伝子の流入探知技術の確立をめざす。



I 第5期中期計画(案)について (計画期間:令和8年度～令和12年度)

- ◆ 令和7年11月議会で議決された第5期中期目標を達成するため、病院機構が本計画を策定し、各センターの役割に応じた高度専門医療を中心とした安全で質の高い医療の提供や、地域の医療機関との連携、人材養成や臨床研究等を通じ、府域の医療水準の向上に向けた取組を推進

1 府民に提供するサービスその他業務の質の向上

大阪急性期・総合医療センター	・基幹災害拠点病院として、府域の災害拠点病院への支援や府域の災害対応への人材派遣、研修支援 ・高度救命救急センター、三次・二次救急指定医療機関として、ER部の充実等救命救急部門の体制強化
大阪はびきの医療センター	・南河内地域の医療ニーズに応える拠点病院として高度医療(救急医療、がん等に対する専門医療)提供 ・府がん診療拠点病院として、診断から集学的治療、緩和ケアまでの総合的な医療の提供
大阪精神医療センター	・措置入院、緊急措置入院、救急入院等、急性期患者に対する緊急・救急医療及び総合的な医療の提供 ・依存症治療・研究センターとして、専門治療の提供及び調査研究、医療人材の育成、(仮称)大阪依存症対策センターへの必要な協力、認知症に対する医療の提供及び健診・予防事業の推進
大阪国際がんセンター	・がん医療の基幹病院として難治性、進行性及び希少がんをはじめ総合的ながん医療の提供 ・遺伝性腫瘍の早期発見や発症リスクを低減する治療可能性の探求に努め、遺伝カウンセリングの充実を推進
大阪母子医療センター	・総合周産期母子医療センターとして、ハイリスク妊産婦・新生児を中心とした症例と幅広い分娩の受入 ・小児中核病院として、小児がん等の小児難治性疾患や先天性心疾患など高度・専門的な医療を提供

2 業務運営の改善及び効率化

- 外部環境や受療動向の変化に応じた必要な医療機能や病床規模についての柔軟な検討及び再編、適正な人員配置による効率的な経営の実施
- 新患者の確保及び病床の効率的運用や診療単価の向上など収入の確保、材料や経費の縮減など費用抑制の取組
- AI等の活用による診療精度の向上や職員の業務負担軽減、ICTの活用による医療情報連携など、医療DXの推進

3 予算、収支計画及び資金計画

府からの適切な運営費負担金の投入のもと、安定的な法人運営に資するための更なる経営改善に計画的に取り組む、経常収支の黒字化をめざす

4 その他業務運営に関する事項

- 府市の独立行政法人の統合について引き続き検討を進める
- 大阪母子医療センターにおいて、建替え整備に向けた取組を進める(事業期間・事業費ともに再検討中)

II 経営改革に向けた取組 (府立病院機構経営改革プラン(案)※)

※府と機構が一体となり令和7年10月に策定

めざすべき方向性

- ◆ 高度専門医療の提供や府域の医療水準の向上を支える役割を果たしていけるよう、将来の医療需要なども見据えた効率的かつ質の高い医療提供の実現

【経営改善目標】 ① 早期に経常収支比率100%以上を達成 ② 令和17年度までに累積欠損を解消

収入の確保・支出の抑制等の経営改善

地域医療ニーズ等に対応するための機能強化

毎年度の決算状況、社会環境の変化等を勘案し、取組内容の検証・見直しを実施

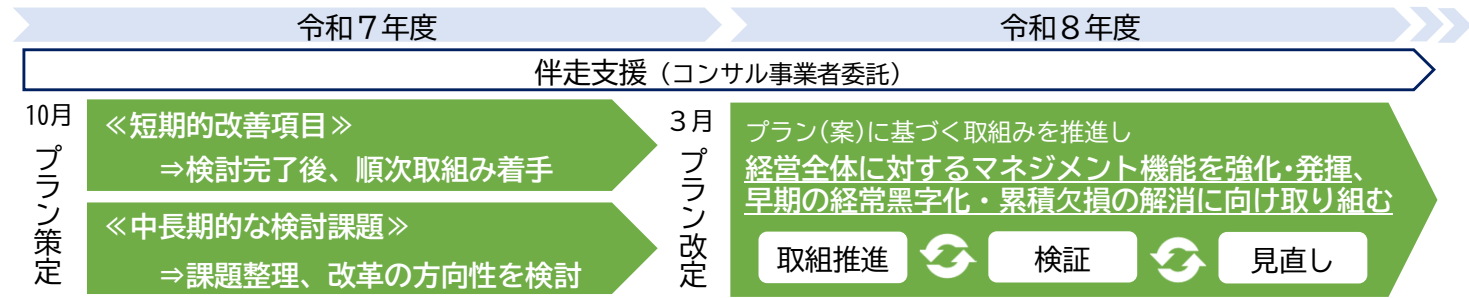
改革の取組・医療提供を支える運営費負担金のあり方の見直し

令和7年度下半期の検討や取組内容を踏まえ、令和8年3月末に本プラン(案)を改定予定

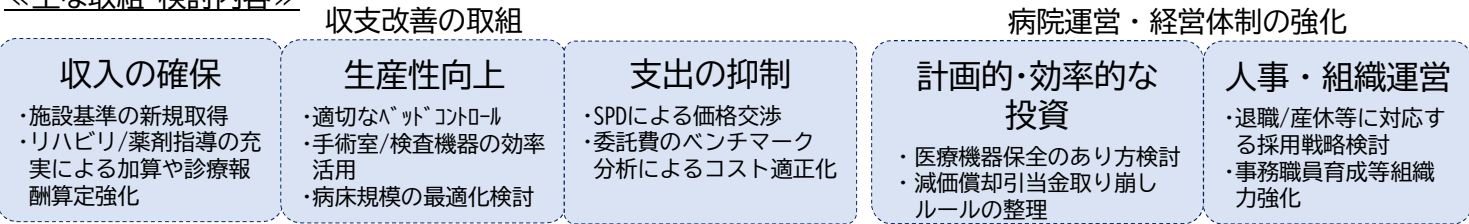
1 具体的な取組について

(1) 経営改善の取組推進

◆ 伴走支援を行いながら、短期的取組の着実な推進と、中長期的な取組について詳細な検討を継続して実施



「主な取組・検討内容」



(2) 地域医療ニーズ等に対応するための機能強化と病床規模の最適化

◆ 少子高齢化等により変化する患者・地域ニーズへの対応力強化や、それを踏まえた病床規模の最適化について検討

① 大阪急性期・総合医療センター

医療ニーズが見込まれる高度急性期病床の増床や集約といった高度急性期の機能強化を図るなど、病棟機能の再編等を検討。診療報酬の改定状況等も踏まえた病棟の最適な運用など、中長期的な視点での検討を進めていく

② 大阪はびきの医療センター

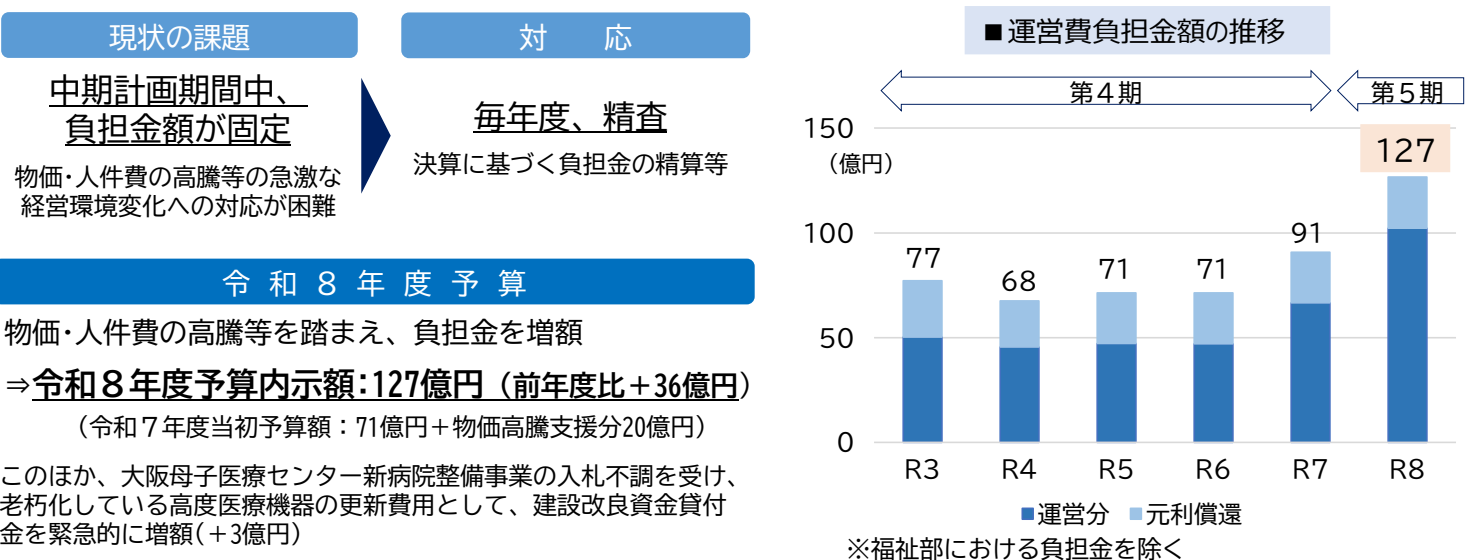
入院需要の変化等を踏まえ、暫定的に病床を休床(52床)し、病床再編で生まれた看護師のマンパワーを手術室や外来部門に配置するなど、がんをはじめとする手術体制や、救急の受入体制の強化などの検討を進めていく

③ 大阪精神医療センター

地域ニーズに沿った効率的・効果的な医療提供体制を構築するため、精神一般病床の一部を休床(50床)し、病床のあり方を検討。長寿健康科学センター(仮称)を令和8年度中に設置し、依存症・認知症への対応力の向上を図る

2 運営費負担金のあり方の見直し

◆経営環境・医療ニーズの変化、医療機器の高度化・高額化への対応など、現行の課題・論点について整理したうえで、経営の安定と継続的な改革の取組を支えていくため、運営費負担金のあり方について見直しを実施



令和7年11月21日に閣議決定された国の「**強い経済**」を実現する**総合経済対策**を受け、府において、**医療機関等が物価・賃金上昇に直面する厳しい状況**であることを踏まえ、府民が安心して医療サービスを受けられる体制を整備するための**緊急支援等**を行う。

緊急支援

【総額 176億296万円】

(令和7年度補正予算額 110億6,713万円、令和8年度当初予算内示額 65億3,583万円)
補正(5号)令和7年11月議会で議決 ※令和8年度に繰越あり

1 医療・介護等支援パッケージ(医療分野)【総額 114億3,883万円】(補正 49億300万円、当初 65億3,583万円)

支援メニュー	予算	施策の概要(厚労省が予定する事業概要(制度詳細未定))																																																																					
①医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援	補正	医療機関や薬局における従事者の処遇改善を支援するとともに、物価上昇の影響に対して支援するため、賃上げ・物価上昇に係る支援として、支援金を支給する。 【対象】有床診療所・医科無床診療所・歯科診療所・保険薬局・訪問看護ST 【支給額】施設種別ごとに以下のとおり <table><tr><td colspan="2"><有床診療所></td><td colspan="2"><医科無床診療所・歯科診療所></td><td colspan="3"><保険薬局></td><td colspan="2"><訪問看護ST></td></tr><tr><td>1床あたり</td><td>支援額</td><td>1施設あたり</td><td>支援額</td><td>1施設あたり</td><td colspan="3">支援額 (1法人当たりの薬局数に応じて傾斜配分)</td><td>1施設あたり</td><td>支援額</td></tr><tr><td>賃金</td><td>7.2万円</td><td>医科無床診療所</td><td>賃金 15.0万円</td><td>賃金</td><td>～5店舗</td><td>6～19店舗</td><td>20店舗～</td><td>賃金</td><td>22.8万円</td></tr><tr><td>物価</td><td>1.3万円</td><td>歯科診療所</td><td>賃金 15.0万円</td><td>物価</td><td>～5店舗</td><td>6～19店舗</td><td>20店舗～</td><td>物価</td><td>(介護より)</td></tr><tr><td>合計</td><td>8.5万円</td><td>合計</td><td>物価 17.0万円</td><td>合計</td><td>～5店舗</td><td>6～19店舗</td><td>20店舗～</td><td>合計</td><td>22.8万円</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>合計 32.0万円</td><td></td><td>～5店舗</td><td>6～19店舗</td><td>20店舗～</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>合計 32.0万円</td><td></td><td>～5店舗</td><td>6～19店舗</td><td>20店舗～</td><td></td><td></td></tr></table> ※病院に対しては国からの直接執行を予定。 なお、病院の支給額は、1床あたり19.5万円(賃金分8.4万円、物価分11.1万円)に、別途救急受入件数等による加算額あり。	<有床診療所>		<医科無床診療所・歯科診療所>		<保険薬局>			<訪問看護ST>		1床あたり	支援額	1施設あたり	支援額	1施設あたり	支援額 (1法人当たりの薬局数に応じて傾斜配分)			1施設あたり	支援額	賃金	7.2万円	医科無床診療所	賃金 15.0万円	賃金	～5店舗	6～19店舗	20店舗～	賃金	22.8万円	物価	1.3万円	歯科診療所	賃金 15.0万円	物価	～5店舗	6～19店舗	20店舗～	物価	(介護より)	合計	8.5万円	合計	物価 17.0万円	合計	～5店舗	6～19店舗	20店舗～	合計	22.8万円				合計 32.0万円		～5店舗	6～19店舗	20店舗～						合計 32.0万円		～5店舗	6～19店舗	20店舗～		
<有床診療所>		<医科無床診療所・歯科診療所>		<保険薬局>			<訪問看護ST>																																																																
1床あたり	支援額	1施設あたり	支援額	1施設あたり	支援額 (1法人当たりの薬局数に応じて傾斜配分)			1施設あたり	支援額																																																														
賃金	7.2万円	医科無床診療所	賃金 15.0万円	賃金	～5店舗	6～19店舗	20店舗～	賃金	22.8万円																																																														
物価	1.3万円	歯科診療所	賃金 15.0万円	物価	～5店舗	6～19店舗	20店舗～	物価	(介護より)																																																														
合計	8.5万円	合計	物価 17.0万円	合計	～5店舗	6～19店舗	20店舗～	合計	22.8万円																																																														
			合計 32.0万円		～5店舗	6～19店舗	20店舗～																																																																
			合計 32.0万円		～5店舗	6～19店舗	20店舗～																																																																
②医療分野における生産性向上に対する支援	当初	業務効率化・職場環境改善に資するICT機器等の導入等を行う病院に対して必要経費を支援し、医療分野の生産性向上を図る。 【対象】病院 【支給額】1病院当たり8,000万円(上限)																																																																					
③施設整備促進支援	当初	現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備が困難となっている医療機関を対象として、建築資材高騰分等の補助を行う。																																																																					
④産科・小児科医療機関等に対する支援	当初	周産期・小児医療体制の維持・確保のため、分娩が減少している分娩取扱施設や地域に不可欠な小児医療等の拠点となる機能を持つ病院に対し支援を行う。																																																																					

2 重点支援地方交付金 【補正 61億6,413万円】

支援メニュー	予算	施策の概要
医療機関等・公衆浴場事業者への光熱費等支援	補正	エネルギー・食料品価格等の高騰の影響を受けている医療機関等や公衆浴場の負担軽減を図り、安定的な事業継続を支援するため、物価高騰及び食材料費高騰に対する一時支援を実施する。 ■ 医療機関等への支援 (1)物価高騰対策一時支援金 【対象】病院・有床診療所・医科無床診療所・歯科診療所・保険薬局・訪問看護ST・助産所・施術所・歯科技工所 【支給額】病院、2床以上の有床診療所 30,000円×許可病床数、左記以外 60,000円 (2)食材料費高騰対策一時支援金 【対象】病院・有床診療所 【支給額】12,900円×許可病床数 ■ 公衆浴場事業者への燃料費支援 一般公衆浴場へ燃料費(重油)の高騰分の経費(1施設当たり9,000円)を補助

≪その他≫

- ・医療施設の非常用自家発電設備、燃料タンク、受水槽、給水設備の整備等への補助(補助対象拡充分)
- ※公立病院が対象に追加、浸水想定区域内の要件が撤廃
- ・災害時のJDAT(日本災害歯科支援チーム)による歯科保健医療活動の実施に必要な器具・器材の整備への補助

健康医療部 (措置状況)

(別添様式)

令和7年度 大阪府施策についての提言回答

<項目>

2 2. 世界に誇る大阪 IR 実現に向けた取組と観光分野の基幹産業化

夢洲第2期区域マスタープランについては、万博レガシーについて関係者との協議結果を踏まえ記載内容を更新した Ver.2.0 (案) が公表された。このマスタープランを踏まえ、民間事業者の募集が今年度後半に開始される。夢洲第2期区域の国際観光拠点の形成に向けては、隣接する IR (夢洲第1期区域) との連携による相乗効果の最大化を図ること。

大阪 IR は、大きな経済波及効果や雇用創出効果に加え幅広い産業分野の活性化が見込まれており、日本が観光立国を推進する上で重要な取組である。このため、ラスベガスのような大型のコンベンションや企業のプライベートイベントの誘致、エンターテインメントショーの充実、府域のナイトコンテンツ強化等による 24 時間観光都市化に向けた検討を進めること。併せて、新たな舟運ルートの発掘・創出事業(兵庫・大阪連携事業)については、兵庫県だけでなく他府県に広げるなど夢洲の地の利を活かした水上交通網の拡充を図ること。

さらに、IR 区域整備の意義の 1 つに、大阪のさらなる成長に向けた観光分野の基幹産業化が掲げられている。その実現に向けた府域や関西・西日本・日本各地への送客機能の充実に加え、大阪観光局(DMO)や他地域の DMO との連携を深めることで裾野を拡げ、日本観光のゲートウェイを形成し、経済全体への波及効果の最大化を図ること。そして、IR の成功には府民理解が欠かせない。このため、ギャンブル等依存症対策の実効性の確保と府民向けに実施している大阪 IR 説明会での具体的な説明に努め、一層の理解向上を図ること。

<回答>

ギャンブル等依存症は、カジノがない現在においても喫緊に取り組むべき重要な課題であり、その依存症対策については、予防と、早期発見・早期介入により、依存症の本人やその家族等に対する支援の充実を図るなど、対策を総合的に推進することが重要です。

ギャンブル等依存症対策については「第2期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づき、啓発や依存症の本人及び家庭等を対象とした回復プログラムを実施しているほか、IR 事業者が各種規制をはじめ自主的な予防等の対策を講じる計画としています。今年度は、第3期計画の策定に向けて議論を進めているところであり、今後、第3期計画において、医療機関や民間支援団体等と連携して、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に進めていきます。

IR の実現に向けては、府民の理解を深めていくことが重要であると認識しており、これまで、セミナーや出前講座、広報紙、動画やパンフレットなど、様々なツ

ールを活用して情報発信に努めてきました。令和5年度より、区域整備計画の説明と質疑応答に特化した「説明会」として実施しています。また、公募型プロポーザル方式により選定した事業者の専門的なノウハウも取り入れ、主要駅でのポスター掲出やインターネット広告など、大阪IRに関する興味関心を喚起し、大阪府市のホームページの詳細な情報へと誘導し、大阪IRについての理解が深まるよう取り組んでいます。

今後も、情報発信の内容の充実を図りながら、効果的・効率的な広報を実施し、より多くの府民・市民の方の理解が深まるよう取り組んでいきます。

<担当部課名>

（複数関係課にまたがる場合、すべての部課名をご記入ください。）

IR推進局 推進課

企画課

健康医療部 地域保健課

<回答送付先>ishin@gikai.pref.osaka.jp（大阪維新の会府議団控室）

(別添様式)

令和 7 年度 大阪府施策についての提言回答

<項目>

7.民泊の実態調査と厳格な制度運用による指導啓発

民泊は大阪の宿泊施設の不足を補う目的で導入され、多様な宿泊ニーズに対応できるものとして認知・活用されている。一方で、ここ数年、民泊施設の騒音やゴミ出し等による近隣住民とのトラブルが大阪市内を中心に増加し続けており、無許可の違法民泊も問題になっている。こういったトラブルは民泊が集積する大阪市内にとどまらず、市外においても発生しており、心配の声が上がっている。民泊を地域に根付いた持続可能な仕組みとして機能させるためには、利便性と住民の安心・安全を両立する制度設計が不可欠である。

そこで、無許可営業の厳格な取締やプラットフォーム事業者への規制強化、通報窓口の周知徹底、市町村の対応体制への支援等、しっかりと現状把握と制度の抜本的強化・見直しを含めた適正な運用を求める。

<回答> ※下線部について回答

- 府では、民泊施設に立入検査を実施しており、問題がある場合には、事業者に対して指導を行い改善させています。
- 民泊に関する通報窓口については、府ホームページや市町村広報への掲載等により周知しているところであり、違法民泊疑いの通報や民泊に関するトラブル等の相談が保健所等にあった場合は、速やかに現地確認を行い、必要に応じ指導等を行っています。無許可施設と判断した場合は、直ちに営業を止めるか、許可等を取得するよう厳しく指導しています。
なお、特区民泊については、令和 7 年 11 月、大阪市の取扱いに合わせて、処分基準に基づく行政処分等の取扱要領を制定したところであり、引き続き指導の徹底を図ります。
- 民泊の設置及び運営については、市町村とも情報共有や連携しつつ、適切に行われるよう今後とも取り組んでいきます。

<担当部課名>

(複数関係課にまたがる場合、すべての部課名をご記入ください。)

健康医療部生活衛生室環境衛生課

<回答送付先>ishin@gikai.pref.osaka.jp (大阪維新の会府議団控室)

(別添様式)

令和7年度 大阪府施策についての提言回答

＜項目＞

3 子ども輝く未来創造都市・大阪

(6) 学校現場でのギャンブル等依存症に対する意識調査と情報周知の徹底

ギャンブル等依存症対策基本法の改正に伴い、オンラインカジノに対する法改正が行われた。予防教育の観点から、まずは、学校現場で児童・生徒や教職員を対象に、オンラインカジノについての意識調査を行うとともに、オンラインカジノをはじめギャンブル等依存症に対する適切な情報周知の徹底を図ること。

＜回答＞

- これまで、法改正に先駆けてオンラインカジノは違法であることを周知する啓発チラシを高等学校等に配布するとともに、高等学校等での授業に活用できる補助教材を作成し、教員向けの研修会や高校生向けの出前授業などを実施しているところ。
- 令和7年度には、若年層を対象とした違法オンラインギャンブル等や相談窓口を取り上げた啓発動画を制作し、教育庁を通じて、府内の全高等学校に周知するとともに、3年生を対象に当該動画の理解度等を測る意識調査を実施する予定。
- 令和7年度末に策定予定の第3期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画において、学校等での若年層向け予防教育の強化を重点施策に位置づける予定としており、引き続き、オンラインカジノが違法であることをはじめギャンブル等依存症に対する適切な情報周知の徹底を図る。

＜担当部課名＞

健康医療部 保健医療室 地域保健課
教育庁 教育振興室 保健体育課

＜回答送付先＞ishin@gikai.pref.osaka.jp（大阪維新の会府議団控室）

(別添様式)

令和 7 年度 大阪府施策についての提言回答

<項目>

4 誰もが健やかに暮らせる健康寿命都市・大阪

1. 困難な状況にあるこどもや女性、性暴力被害者に対する支援体制の強化

大阪府内には、子どもの貧困や DV・性的暴力を受けた女性、さらには性暴力被害者といった複合的かつ深刻な課題を抱える人々が数多く存在している。近年では、育児放棄といった深刻なケースも報告されており、泉佐野市が独自に「赤ちゃんポスト」の設置を目指すことでも話題になった。これらの問題の背景には、経済的困窮、家庭内不和、暴力や虐待、孤立、社会的支援を要するなどの構造的な要因が複雑に絡み合っている。課題解決に向けた横断的かつ包括的な対応がなされるよう、以下に提言する。

府が実施した子どもの貧困に関する実態調査では、依然として困窮度の高い家庭の存在が明らかになっている。貧困率の高いひとり親世帯に対しては、他の自治体でも実施されている養育費用の立替支援や児童扶養手当の上乗せ支援といった経済的支援を府域の全市町村で実施できるよう支援すること。実態調査で明らかとなった個別の事情に対応できる支援体制を構築するほか、未成年者が闇バイトや売春に巻き込まれないよう官民が連携し、オール大阪で設置している会議体において、根本的な課題解決に取り組むこと。また、地域ごとに子どもが安心して過ごせる居場所や食事提供の拠点を整備し、孤立や虐待の防止につながる包括的な支援を進めること。

DV や性的暴力、育児困難、社会的支援を要するなど様々な困難を抱える女性が支援を必要としており、配偶者暴力相談支援センターの周知を強化するほか、女性相談支援員の全市町村配置を推進し、府域の困難を抱える女性に対する相談支援体制を強化すること。

なお、嬰兒遺棄のような痛ましい事件が起きることのないよう、予期せぬ妊娠の相談窓口「にんしんSOS」の一層の周知や、特に支援が必要な妊婦を把握した場合の要保護児童対策地域協議会での見守り、出産後の継続的な支援など、子どもの命を守るとともに、虐待の防止につながる取組を引き続き進めること。

<回答>

- 令和5年に実施した実態調査において、世帯可処分所得の中央値や家計状況は前回より改善しているが、困窮世帯では子どもに回す余裕まで至っていません。
常勤・正規職員の母親の割合は増加した一方、困窮度Ⅰ世帯に占める母子世帯の割合、母子世帯の非正規雇用率とも、依然として高いということが明らかとなっています
- 実態調査の結果を踏まえ、関係部局が連携しながら教育・就労・生活支援等の総合的取組みを進めるとともに、国や市町村と連携し、子どもの貧困の解消に向けた総合的な対策の推進に取り組んでまいります。
- 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る制度です。
- 令和6年 11 月から、児童扶養手当の所得制限限度額の引上げや、第3子以降の多子加算額の増額が行われたが、ひとり親家庭の生活実態を十分考慮した手当額の引上げ及び所得制限の緩和を講じるなど更なる制度の拡充について国へ要望しています。
- 社会情勢や国の動向を見ながら、さらに支援が拡大するよう、引き続き国に対し要望してまいります。
- 養育費は、こどもの健やかな成長のために不可欠なものであり、負担すべき義務を負う者が誠実に履行すべきものです。
- 一方で、母子家庭の養育費の受給状況は、府の調査において、全国同様、約3割であり十分とは言えません。
- 国（法務省）においては、こどもの利益を確保するため、子1人当たり月額2万円とすることや養育費の取決めがない場合でも法定養育費の差押えができる法定養育費制度の導入など、養育費の支払確保に向け令和8年4月1日の民法改正の施行準備を進めているところです。
- また、府においても、養育費の履行を確保するため、強制執行に要した弁護士費用等について国庫を活用し補助を実施しています。
- 引き続き、国の動向を注視し、養育費確保に向けて府として必要な支援のあり方を検討してまいります。
- なお、養育費用の立替については、現行の国補助制度の対象でなく、仮に養育費用が支払われない場合、国の責任において実施すべきナショナルミニマムにより対応されるべきものです。

- 府では、経済的な困窮度に関わらず、青少年が闇バイト等のSNSに起因する犯罪に巻き込まれないよう、学校関係者やPTA協議会、府警察、さらには携帯電話事業者等の民間事業者とともに実行委員会を組織し、青少年のネット・リテラシー向上に向けた取組を行っているところです。
- 引き続き、関係機関と連携しながら、青少年をSNSに起因する犯罪から守る取組みを推進してまいります。
- 子どもの居場所づくりに取り組む市町村に対し、新子育て支援交付金により支援しているところです。また、公民館・商店街等様々な場所での立ち上げを支援する国の補助事業についても、市町村へ活用を案内しています。
- 大阪府の配偶者暴力相談支援センターとしては、配偶者暴力相談支援センターの機能を有する女性相談センター及び6か所の子ども家庭センターを設置し、市町村の配偶者暴力相談支援センターについては、現在、大阪市、堺市、吹田市、枚方市、茨木市、豊中市、松原市、東大阪市の8市において設置されております。
なお、府ホームページに府内配偶者暴力相談支援センターの相談窓口の一覧を掲載し、周知に努めております。
- 女性相談支援員の配置については、「大阪府困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」の基本目標として47市町村のうち、全33市での配置を数値目標として掲げ、令和5年4月時点の14市から令和7年12月時点では24市町となっており、今後も配置を促進してまいります。
- 「にんしんSOS」の周知については、特に若い世代に広く知っていただけるよう、新たにSNSを活用するほか、医療機関や薬局、各種相談窓口等、啓発資材の配布場所の拡充に向け取り組んでいきます。
- 特に支援が必要な妊婦を把握した場合には、要保護児童対策地域協議会において、市町村や子ども家庭センター等の関係機関が連携し、妊娠期から見守り、出産後も継続した支援を行っています。
- 出生後に様々な事情で家族と離れて暮らさざるを得ない子どもについては、子ども家庭センターが里親や乳児院等による養育につなげるなど、適切に対応しています。
- 引き続き、市町村や関係機関と連携し、子どもの命を守り、虐待の防止につながる取組を進めてまいります。

＜担当部課名＞

（複数関係課にまたがる場合、すべての部課名をご記入ください。）

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課

青少年支援課

子育て支援課

家庭支援課

健康医療部 保健医療室 地域保健課

＜回答送付先＞ishin@gikai.pref.osaka.jp（大阪維新の会府議団控室）

(別添様式)

令和7年度 大阪府施策についての提言回答

<項目>

4 誰もが健やかに暮らせる健康寿命都市・大阪

(3) 待たせない診療体制に向けた児童精神医療の体制拡充

発達障がいや情緒的課題を抱える子どもが増加する一方で、児童精神医療の体制は十分とは言えず、診断や治療を必要とする子どもが長期間受診できない状況が続いている。府はこれまで、拠点病院の整備や研修制度を進めてきたが、現場からは「予約が半年先」「継続的に見てもらえない」といった声があり、これらに対応するにはさらなる体制強化が必要である。

待たせない診療体制に向けて、診断・治療の入口を広げて児童精神科や発達外来を有する医療機関を増やし、より多くの子どもが身近な地域で適切な医療を受けられる体制の整備が必要である。府として、市町村や医師会、大学等と連携しながら、広く受診可能な医療提供体制の拡充を進めること。

<回答>

○ 地域で身近な医療機関に受診が可能となるよう、令和7年9月時点で児童思春期の診療が可能な244の医療機関の情報をホームページにて発信している。このうち二次医療圏単位で専門医師を配置した地域拠点医療機関を53機関、専用病床を有する拠点病院を10機関選定し、症状に応じて受診が可能な体制をめざしている。

○ また、地域において、子どもの診断が可能な医療機関の増加や対応力の向上を図るため、大阪精神医療センターが「子どもの心の診療拠点病院」として、診察現場の見学や症例検討会を行うとともに、教職員や保健福祉関係機関の職員との連携会議や研修会等を実施し、医療機関をはじめ、子どもの心に関わる地域の関係機関も含めた連携体制の強化を図っている。

加えて、同センターでは、児童・思春期精神科の専門医である「子どものこころ専門医」取得のための研修機関として育成支援に取り組んでいる。

<担当部課名>

健康医療部 保健医療室 地域保健課

<回答送付先> ishin@gikai.pref.osaka.jp (大阪維新の会府議団控室)

(別添様式)

令和7年度 大阪府施策についての提言回答

<項目>

4 誰もが健やかに暮らせる健康寿命都市・大阪

(4)「大阪依存症センター(仮称)」の早期立上げと支援情報の発信強化

近年、ギャンブル等依存症が社会的課題として深刻さを増している。従来の公営競技やパチンコに加えて急速に普及が進むオンラインカジノ等により、依存症患者は世代や職業を問わず増加傾向にある。これは本人の問題だけでなく、家族関係の破綻や生活困窮、犯罪の温床等社会全体に大きな影響を与えている。

府では、依存症対策拠点「OATIS(大阪依存症包括支援拠点)」をはじめ、医療・相談支援・啓発に取り組んでいるものの、その存在や支援内容が府民に十分に知られていない。そこで、依存症の予防教育や普及啓発、医療体制の整備、治療法の研究、相談支援体制の拡充、人材育成などを体系的に進め「大阪依存症センター(仮称)」を早期に立ち上げること。また、既存の支援策をより効果的に機能させるため、支援情報の可視化と発信強化に取り組むこと。

以上、大阪が日本の依存症支援の先進地となるよう、迅速かつ計画的な体制整備を進め、ギャンブル等依存症に苦しむ当事者とその家族が希望を持てる支援と広報の両輪を強化した総合的な対応を強力に進めること。

<回答>

○ 「(仮称)大阪依存症対策センター」については、昨年度、医療関係者や民間支援団体等が参画する機能検討会議において議論を重ね、「相談・医療・回復へのワンストップ支援」及び「普及啓発・情報発信」の機能について取りまとめを行った。今年度は第3期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画を策定し、令和8年度から10年度までの計画期間中にデジタル技術を活用した新たな相談体制の整備をはじめ、若年層向けの普及啓発やリスクのある方を対象とした支援プログラムの開発など新たなコンテンツの準備や、人材確保・育成などに取り組み、令和11年度のセンター開設をめざして着実に準備を進めていく。

支援情報の可視化と発信強化については、おおさか依存症ポータルサイトにおける依存症に関する正しい知識や府内の医療機関・相談機関等検索、普及啓発リーフレット、イベント情報などの掲載や、SNSでの情報発信などを実施しており、引き続き府民に分かりやすい情報提供を行っていく。

<担当部課名>

健康医療部 保健医療室 地域保健課

<回答送付先>ishin@gikai.pref.osaka.jp (大阪維新の会府議団控室)

(別添様式)

令和 7 年度 大阪府施策についての提言回答

＜項目＞

4 誰もが健やかに暮らせる健康寿命都市・大阪

8.がん予防の取組推進及び医療体制の充実と支援

府のがん検診受診率は依然として全国平均を下回っており、府民の健康維持にとって大きな課題である。特に「検診そのものを知らない」「関心がない」といった、いわゆる無関心層の存在が大きく、周知啓発の見直しと受診の動機付けが必要である。そこで、検診の対象となる年齢層に対して周知・啓発の強化を図ること。

また、がんを治療するにあたり、高い治療効果を目指して集学的治療をしっかりと提供するほか、病院が相互に連携してがん治療の水準向上に努めるとともに、緩和ケアの充実、在宅医療の支援、がん患者や家族等に対する相談支援、がんに関する各種情報の収集・提供等の機能を備え、地域におけるがん医療の充実に取り組むこと。さらに、先進的かつ低侵襲ながん治療、BNCT の臨床応用を推進するため、医療機関や大学、事業者等の関係機関と緊密に連携し、がん治療法としての普及や認知に努めること。

以上、予防から治療までを切れ目なく支える総合的ながん対策に取り組むこと。

＜回答＞

○ がんの早期発見に向けては、「大阪府がん対策推進計画」において、がん検診受診率の目標値を定め、受診率の向上に向けた取組を進めている。

○ 具体的には、無関心層にがん検診を周知・啓発するため、プロスポーツチームや民間企業・大学との連携や、タレントを活用したイベントの実施に加え、SNS 等の活用など、様々な手法による周知啓発に取り組んでいるところ。

○ 引き続き、市町村や企業等と連携し、がん検診の受診率の向上に資する取組を進めていく。

○ また、がんの治療については、がん診療の質の向上をめざし、「大阪府がん診療連携協議会」と連携して、がん診療拠点病院等における集学的治療や多職種におけるチーム医療、緩和ケアの推進などの機能強化に取り組むとともに、好事例の収集や情報共有を行っている。

○ 加えて、二次医療圏ごとに設置されている「がん診療ネットワーク協議会」が行う地域連携やがん患者等に対する相談支援などの取組みを支援することで、地域の実情に応じたがん医療の充実に努めている。

○ 今後とも、「第4期大阪府がん対策推進計画等」に基づき、各課題に応じて、様々な取組みを推進していく。

＜担当部課名＞

（複数関係課にまたがる場合、すべての部課名をご記入ください。）

健康医療部 健康推進室 健康づくり課

＜回答送付先＞ishin@gikai.pref.osaka.jp（大阪維新の会府議団控室）

(別添様式)

令和7年度 大阪府施策についての提言回答

<項目>

5 犯罪のない災害・有事に強い安心安全都市・大阪

(3) 被災者の「命をつなぐ」ための災害応急対策

近年、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害の発生リスクが高まっている。大都市圏である大阪府では、人口の集中と社会インフラの複雑性から災害時の医療対応力が地域全体の被害軽減に直結する。現状、災害時の医療・薬事体制は十分とは言えず、例えば、能登半島地震では医薬品の備蓄情報が不足しており、近隣で調達できたであろうインスリンが手に入らないケースがあったと聞く。また、大阪府北部地震では府保健医療調整本部で活動する災害医療コーディネーターが不足し、活動が長期化した場合のマンパワー不足が生じた。

そこで、地域単位で流通備蓄医薬品の保有量や使用期限等をデータ化して随時共有することにより、災害発生時の迅速かつ的確な供給体制を府域で構築すること。また、災害医療救護体制の中核となる災害医療コーディネーターを養成するための研修を毎年行うほか、薬事分野に特化した研修を行って災害薬事コーディネーターを養成するなど、継続的な人材育成を行うこと。

<回答>

- 大阪府では、大阪府北部地震において災害医療コーディネーターが不足したという課題を受け、養成研修の実施等により災害医療コーディネーターの人材育成に取り組んでいるところ。
- また、令和7年度、地域で活動する災害薬事コーディネーターの養成・配置を行い、災害発生時に府内各地域において、薬局等の稼働状況や避難所等における医薬品ニーズを把握し、保健所や市町村等と連携・調整して、医薬品等の確保や供給を円滑に行う体制整備に取り組んでいる。
- 引き続き、コーディネーターの養成を行うとともに、訓練実施等を通じ、災害医療体制の充実に取り組んでいく。

<担当部課名>

健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課
健康医療部 生活衛生室 薬務課

<回答送付先>ishin@gikai.pref.osaka.jp（大阪維新の会府議団控室）

(別添様式)

令和8年度 大阪府予算についての要望回答

<項目>

4 誰もが健やかに暮らせる健康寿命都市・大阪

(1) 府立病院機構の安定運営に向けた支援強化

大阪府立病院機構は非常に厳しい経営状況に直面しており、病院経営の改善が急務となっている。しかしながら、公立病院では、地域の救急や小児・周産期、災害対応、感染症対応、精神科などの不採算医療や、高度・先進医療などの政策医療を担う地域医療の最後の砦としての重要な役割を果たしている。2040年に向けた、さらなる高齢化や人口減少が見込まれる中、経営改善や経営状況の悪化だけを理由に、本来担うべき医療を提供できなくなることは、府民の命に関わる重大な問題である。府立病院機構としても経営改革に向けた取組を進めることは必要だが、経営改革と並行して、設立団体である府が府立病院機構に対して十分な支援を行うために必要な予算を確保し、引き続き、府立病院機構が地域医療の中核としての役割を果たしていけるよう、安定的な病院運営に取り組むこと。

<回答>

- 府立病院機構が高度専門医療の提供や府域の医療水準の向上を支える役割を果たしていけるよう、府と機構において、将来の医療需要なども見据えた効率的かつ、質の高い医療提供の実現をめざし、令和7年10月に『府立病院機構経営改革プラン(案)』を策定した。
- 同プランに沿って、経営の安定と継続的な改革の取り組みを支えていくため、機構に対する運営費負担金等のあり方を検討し、令和8年度予算案には運営費負担金額を増額するとともに、老朽化している大阪母子医療センターの高度医療機器の更新に対応するため、建設改良資金貸付金を増額して計上する予定。
- 令和8年3月末には、同プラン策定後の検討・取り組み内容を踏まえ、同プランを改定し、今後も府と機構が一体となり、経営改革を図りながら、将来にわたって公的医療機関としての役割を果たし続けられるよう取り組んでいく。

<担当部課名>

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

<回答送付先> ishin@gikai.pref.osaka.jp (大阪維新の会府議団控室)

(別添様式)

令和 8 年度 大阪府予算についての要望回答

<項目>

4 誰もが健やかに暮らせる健康寿命都市・大阪

3.社会全体で支えるべき妊娠・出産体制の構築

泉佐野市において、導入の検討が進められているいわゆる赤ちゃんポストは、匿名での子どもの保護を可能とする最後のセーフティネットとしての役割が期待されるという評価や、親子の命と安全を守る重要な取組との声がある一方で、様々な課題も指摘されている。また、その設置にあたっては、子どもの安全な受け入れ体制、医療機関・児童相談所との連携、緊急時の対応、児童福祉法等に基づく適切な保護措置など、多岐にわたる仕組みづくりが求められることから、基礎自治体だけではなく広域行政である府の積極的な関与が不可欠である。

そこで、泉佐野市が赤ちゃんポストの運用を開始するとなれば、府において、赤ちゃんポストに預け入れられた児童を要保護児童として受け止め、適切に対応できる体制を構築すること。(福祉部) あわせて、府では現在、「にんしん SOS」により妊娠に悩む方への相談体制を整備しているが、その存在が十分に認知されておらず、特に若年層を中心に相談につながらないケースが依然として多いのではないかと。妊娠に関する不安や困難を抱える方が早期に支援へつながるよう、妊婦本人の周囲の大人や関係者も相談可能である点も含め、学校、医療機関、行政窓口、地域団体、SNS 等を通じた周知・啓発のさらなる強化に取り組むこと。(健康医療部)

<回答>

- いわゆる「赤ちゃんポスト」に子どもが預け入れられた場合、泉佐野市には一時保護や措置等の権限はなく、保護者による監護が困難な子どもとして要保護児童通告の対象となり、子どもの一時保護やその後の支援を府の子ども家庭センターが担うことになります。
- 今後、泉佐野市から具体的な事業計画等が府に示されれば、具体的な課題の確認やその解決策の検討、府と市の役割分担等について丁寧に協議・調整を重ね、府における要保護児童の対応に支障が生じることのないよう、体制整備を図っていく必要があると考えています。
- 「にんしん SOS」の周知に関しては、これまで、中学校や高校、一般社団法人日本複合カフェ協会加盟店等のほか、公民連携によりコンビニや大学等、多くの方が訪れる施設でのチラシやカード等の配架に取り組んできたところ。

○ 今後は、特に若い世代に広く知っていただけるよう、新たにSNSを活用するほか、医療機関や薬局、各種相談窓口等、啓発資材の配布場所の拡充に向け取り組み、悩みに気づいた周囲の方において、本人への「にんしんSOS」の案内や「にんしんSOS」への直接の相談を行っていただくことも含め周知していく。

<担当部課名>

福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

健康医療部 保健医療室 地域保健課

<回答送付先>ishin@gikai.pref.osaka.jp（大阪維新の会府議団控室）

(別添様式)

令和8年度 大阪府予算に関する要望回答

<項目>

5 犯罪のない災害・有事に強い安心安全都市・大阪

1. 安定的な性暴力・性被害者支援の取組の推進

本府の性暴力・性被害者支援は、これまでの病院拠点型から医療機関や相談支援機関が面的に連携する連携型へと移行し、必要な支援を迅速かつ継続的に提供できる新たな仕組みとして運用が開始された。また、令和7年度からの委託事業化や移転を契機に、ワンストップ支援センターの名称が「ウィズユーおおさか」へと刷新され、支援機能の充実と認知向上を図る基盤が整備されてきた。こうした体制の転換を確かなものとし、府民がどこにいても適切な支援にアクセスできる環境を実現するため、以下の取組を着実に推進すること。

- ・性暴力・性被害を受けた被害者やその関係者等が安心して相談できるよう、近年の発生件数等を踏まえ、実態に即した体制となるよう「ウィズユーおおさか」の事業予算を確保すること。(危機管理室)

- ・被害者が周囲の目を気にすることなく安心して治療を受けることができるよう、連携協力できる病院やクリニック等を増やす取組を推進するとともに、被害者に寄り添った治療が提供できるよう研修を行うなど、被害者理解に取り組むこと。(危機管理室／健康医療部)

- ・性暴力・性被害に関する相談窓口として「ウィズユーおおさか」を認知する人が100%となるよう周知を強化すること。また、周知に要するチラシの内容については、被害者やその関係者等の意見も取り入れながら作成すること。(危機管理室)

- ・性暴力や性被害に対する理解が進み、被害者も加害者も生み出すことのない社会に向け、知見を有する様々な主体と連携し、すべての世代・性別の総合的な性教育の取組を教育庁と連携しながら進めること。(危機管理室／教育庁)

<回答>

○ 「ウィズユーおおさか」については、令和8年度においても24時間365日の相談支援のほか、カウンセリングや初期診療など、被害や相談等の実態に即した体制を構築できるよう必要な費用を計上のうえ、予算を要求しているところ。

○ 連携する「協力医療機関」については、これまで10病院(産婦人科のみ)だったが、関係団体を通じて医療機関に協力依頼を行ったところ、新たに約30機関(産婦人科、小児科、精神科、肛門外科、泌尿器科等)から賛同いただき、合計約40機関に増加。

加えて、被害者に寄り添った診療を提供できるよう、府、「ウィズユーおおさか」、「協力医療機関」で構成する「性暴力被害者支援ネットワーク連携・協力会議」において、診療事例の共有や、診察マニュアルの改訂等についての意見交換等を

実施した。

- また、令和7年10月の移転を契機として、ホームページやSNS、チラシ等により、重点的に「ウィズユーおおさか」の周知に取り組んでいるところ。周知啓発チラシについては、「大阪府性犯罪・性暴力被害者支援有識者検討会議」の委員である有識者や、オブザーバーである被害当事者からの意見を反映して作成した。
- 最後に、「包括的な性教育」については、10代の被害が多いことから、周知啓発チラシを府内の全高校生の配布するほか、「ウィズユーおおさか」から講師を派遣し、市町村等で講義を行うなど、取組を進めていく。

加えて、有識者検討会議では、教職員も理解を深める必要があるとの意見があったことから、今後、教育庁とも連携し、教職員が参加する研修会等において、被害者支援の取組や窓口の紹介、生徒から相談があった際の注意事項や心得等を周知していく予定。

<担当部課名>

政策企画部危機管理室治安対策課

健康医療部保健医療室地域保健課

教育庁教育振興室保健体育課

<回答送付先> ishin@gikai.pref.osaka.jp（大阪維新の会府議団控室）